

Técnicas de primeros auxilios en primera infancia

Breve descripción:

Este componente desarrolla las técnicas de primeros auxilios en primera infancia, así como la valoración inicial y la atención de emergencias. Integra técnicas de soporte vital básico, manejo de lesiones, movilización, comunicación y articulación con el sistema de salud, fortaleciendo la capacidad de respuesta oportuna y segura.

Tabla de contenido

Introducción	4
1. Anatomía y fisiología básica.....	7
1.1. Sistema circulatorio	8
1.2. Sistema respiratorio.....	11
1.3. Sistema tegumentario.....	13
1.4. Sistema musculoesquelético.....	16
1.5. Relación con la atención de emergencias	18
2. Evaluación inicial del lesionado	22
2.1. Nivel de conciencia	24
2.2. Valoración de la respiración.....	26
2.3. Valoración del pulso.....	30
2.4. Identificación de signos de alarma.....	33
3. Soporte vital básico en primera infancia.....	36
3.1. RCP en lactantes	37
3.2. Obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño (OVACE)	39
3.3. Uso del desfibrilador externo automático (DEA)	42
4. Lesiones, traumatismos y movilización.....	45
4.1. Atención de lesiones en primeros auxilios	46

4.2. Manejo de lesiones osteomusculares	47
4.3. Manejo de traumas	52
4.4. Movilización y traslado del lesionado	53
4.5. Principios de la movilización segura.....	55
4.6. Tipos de movilización.....	57
4.7. Técnicas de traslado.....	58
5. Situaciones específicas y enfermedades prevalentes.....	61
5.1. Atención de situaciones específicas	62
5.2. Principales enfermedades prevalentes	66
5.3. Signos de alarma	69
6. Comunicación, emergencias y cadena de custodia	73
6.1. Primeros auxilios psicológicos y comunicación	74
6.2. Articulación con el sistema de emergencias	79
6.3. Cadena de custodia	83
Síntesis	87
Glosario	89
Referencias bibliográficas	91
Créditos.....	92

Introducción

Las técnicas de primeros auxilios en la primera infancia representan una herramienta esencial para proteger la vida y la integridad de un niño o una niña ante una situación de emergencia. Sin embargo, su aplicación efectiva no depende únicamente de conocer los procedimientos, sino de comprender el funcionamiento del cuerpo en esta etapa de la vida, reconocer los signos de alarma y actuar con calma y seguridad mientras llega la atención especializada.

En este componente formativo se desarrollan las bases necesarias para adquirir estas competencias, permitiendo al talento humano en formación intervenir de manera oportuna y responsable ante una emergencia en la primera infancia, contribuyendo a salvar vidas y a reducir las consecuencias de una lesión mientras se activa el sistema de emergencias.

El desarrollo de los contenidos se presenta de manera progresiva: inicia con la anatomía y fisiología básica y la evaluación inicial del lesionado; continúa con el soporte vital básico y el manejo de lesiones y traumatismos; y finaliza con la atención de situaciones específicas y la comunicación con el niño, la niña y sus cuidadores durante la emergencia. Para ampliar la información, se recomienda consultar el material audiovisual que acompaña esta sección.

Video 1. Técnicas de primeros auxilios en primera infancia



[Enlace de reproducción del video](#)

Transcripción del video. Técnicas de primeros auxilios en primera infancia

Una caída en el parque, una quemadura en la cocina o un ahogo durante la comida pueden convertirse, en segundos, en una emergencia que compromete la vida de una niña o un niño.

En la primera infancia, actuar a tiempo y con la técnica adecuada marca la diferencia entre una atención oportuna y un desenlace muy grave.

Este componente formativo enseña a reconocer cuando algo no está bien en el cuerpo de un menor y a realizar la evaluación inicial del lesionado, observando el nivel de conciencia, la respiración y el pulso para priorizar la atención, siguiendo los protocolos establecidos para el primer respondiente.

Transcripción del video. Técnicas de primeros auxilios en primera infancia

También muestra las técnicas de soporte vital básico: la reanimación cardiopulmonar en lactantes y en niños, el manejo de la obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño y el uso del desfibrilador externo automático, así como la atención de heridas, hemorragias, quemaduras y la movilización segura del lesionado.

De igual manera, enseña a actuar ante situaciones específicas como convulsiones, picaduras, mordeduras e intoxicaciones, resaltando la importancia de mantener una comunicación calmada con el niño y sus cuidadores, y de activar a tiempo los servicios de emergencia.

Conocer estas técnicas permite actuar con serenidad, precisión y responsabilidad mientras llega la atención especializada. En Colombia, una respuesta oportuna y bien fundamentada protege la vida y el bienestar de las niñas y los niños en los entornos donde crecen, aprenden y se desarrollan.

1. Anatomía y fisiología básica

La anatomía y la fisiología constituyen la base para comprender el funcionamiento del cuerpo humano y su relación con la atención de emergencias. La anatomía estudia las estructuras corporales, mientras que la fisiología explica el funcionamiento de los órganos y sistemas (Tortora y Derrickson, 2021). En la primera infancia, este conocimiento adquiere especial importancia debido a las características propias del desarrollo, como la mayor frecuencia respiratoria y cardíaca, el menor tamaño de las vías aéreas y el crecimiento continuo de las estructuras corporales. Estas condiciones requieren una actuación cuidadosa y adaptada a las necesidades de la población infantil.

Los sistemas corporales actúan de manera coordinada para mantener la vida, proteger el organismo y permitir el movimiento. Su reconocimiento facilita la valoración inicial y la identificación de alteraciones durante una emergencia. Para comprender sus funciones principales, se describen los siguientes sistemas:

- a) **Sistema circulatorio:** transporta la sangre, el oxígeno y los nutrientes por todo el organismo. Su reconocimiento permite valorar el pulso e identificar alteraciones de la circulación.
- b) **Sistema respiratorio:** permite el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Su funcionamiento orienta la identificación de dificultades respiratorias o de una obstrucción de la vía aérea.
- c) **Sistema tegumentario:** protege el cuerpo mediante la piel y contribuye a regular la temperatura. Su valoración permite identificar heridas, quemaduras y signos de infección.

d) Sistema musculoesquelético: brinda soporte al cuerpo y permite el movimiento. Su reconocimiento facilita la identificación de fracturas, esguinces y luxaciones.

La comprensión integrada de estos sistemas favorece una valoración inicial adecuada, la identificación de riesgos y la aplicación segura de las técnicas de primeros auxilios. En la primera infancia, una intervención oportuna puede contribuir favorablemente a la evolución de la persona afectada (Ministerio de Salud y Protección Social, 2018).

Para valorar adecuadamente una emergencia, es necesario reconocer cómo actúan los sistemas corporales y qué signos pueden indicar una alteración en su funcionamiento. Este proceso comienza con el sistema circulatorio, cuya evaluación permite identificar posibles riesgos para la vida.

1.1. Sistema circulatorio

El sistema circulatorio transporta la sangre por todo el organismo y permite que las células reciban el oxígeno y los nutrientes necesarios para su funcionamiento. También recoge dióxido de carbono y otras sustancias de desecho para facilitar su eliminación. Está conformado por el corazón, los vasos sanguíneos y la sangre, elementos que actúan de manera coordinada para conservar el equilibrio del organismo (Tortora y Derrickson, 2021).

La circulación sanguínea comprende dos recorridos relacionados. En la circulación pulmonar, la sangre se desplaza desde el corazón hacia los pulmones, donde libera dióxido de carbono y recibe oxígeno antes de regresar al corazón. En la

circulación sistémica, la sangre oxigenada sale del corazón, llega a los diferentes órganos y tejidos y retorna con menor cantidad de oxígeno (Tortora y Derrickson, 2021).

Durante la primera infancia, la valoración de la circulación permite reconocer signos que pueden indicar una alteración y requerir atención prioritaria. La frecuencia y la calidad del pulso, el color y la temperatura de la piel, así como el tiempo de llenado capilar, aportan información sobre el flujo sanguíneo. Estos signos deben interpretarse de manera conjunta y teniendo en cuenta el estado general de la persona afectada.

Cada estructura del sistema circulatorio cumple una función específica en el recorrido y la distribución de la sangre. El reconocimiento de estas funciones facilita la comprensión del proceso circulatorio y de las alteraciones que pueden presentarse durante una emergencia. Sus principales componentes son los siguientes:

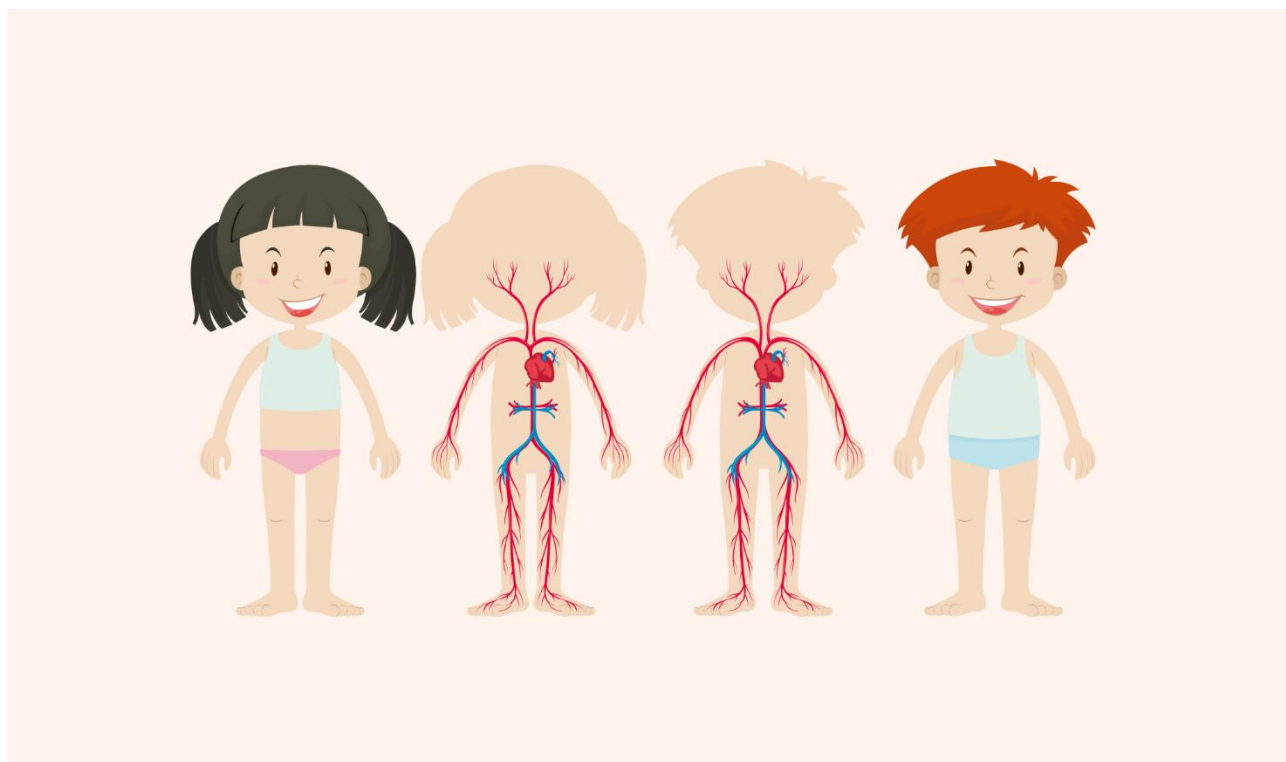
- **Corazón:** órgano muscular que impulsa la sangre mediante contracciones rítmicas y mantiene su circulación hacia los pulmones y el resto del organismo. Durante una emergencia, la valoración del pulso contribuye a reconocer posibles alteraciones de la actividad cardíaca.
- **Arterias:** vasos sanguíneos que conducen la sangre desde el corazón hacia los órganos y tejidos. En los lactantes, la arteria braquial constituye uno de los puntos utilizados para verificar el pulso durante la valoración de la circulación.
- **Venas:** vasos sanguíneos que retornan la sangre desde los tejidos hacia el corazón. Este recorrido permite que la sangre con menor cantidad de oxígeno sea dirigida posteriormente hacia los pulmones para participar nuevamente en el proceso de oxigenación.

- **Capilares:** vasos sanguíneos microscópicos que conectan las ramificaciones más pequeñas de las arterias y las venas. En ellos se produce el intercambio de oxígeno, nutrientes y sustancias de desecho entre la sangre y los diferentes tejidos.

El reconocimiento de estas estructuras permite relacionar el funcionamiento circulatorio con signos como palidez, piel fría, sangrado, pulso débil o llenado capilar prolongado. Durante una emergencia, estos hallazgos deben valorarse de forma conjunta para identificar oportunamente un posible compromiso de la circulación y solicitar la atención correspondiente.

La siguiente figura representa la ubicación del corazón y la distribución general de los principales vasos sanguíneos. Su observación permite comprender cómo estas estructuras conforman una red que mantiene el recorrido de la sangre por el organismo.

Figura 1. Sistema circulatorio en la primera infancia



El adecuado funcionamiento del organismo depende de la acción coordinada de sus diferentes sistemas. En este proceso, la respiración cumple una función esencial al permitir la incorporación del oxígeno necesario para la vida y la eliminación del dióxido de carbono, aspectos que se abordan en el sistema respiratorio.

1.2. Sistema respiratorio

La respiración es un proceso esencial para mantener el funcionamiento del organismo, ya que permite incorporar el oxígeno que requieren las células y eliminar el dióxido de carbono que producen. En este proceso intervienen diferentes estructuras

encargadas de conducir el aire y realizar el intercambio gaseoso. Durante la primera infancia, las vías aéreas son más estrechas y la frecuencia respiratoria es mayor; por ello, existe mayor riesgo de obstrucción y dificultad respiratoria (Tortora y Derrickson, 2021).

Las estructuras respiratorias actúan de manera coordinada durante la entrada y salida del aire. Reconocer su función permite comprender el proceso respiratorio e identificar oportunamente posibles alteraciones. Sus principales componentes son los siguientes:

- a) **Vías respiratorias:** conducen el aire desde la nariz o la boca hasta los pulmones, a través de la faringe, la laringe y la tráquea. Por ejemplo, un alimento o un objeto pequeño puede bloquear este recorrido y ocasionar una obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño (OVACE).
- b) **Pulmones:** realizan el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre el aire y la sangre. Por ejemplo, una alteración en este proceso puede manifestarse mediante dificultad para respirar, respiración acelerada o coloración azulada en los labios.
- c) **Músculos** respiratorios: permiten los movimientos de inspiración y espiración mediante la acción del diafragma y los músculos intercostales. Por ejemplo, el hundimiento de la piel entre las costillas, denominado tiraje, puede indicar un aumento del esfuerzo respiratorio.

La observación de la respiración permite reconocer signos de alarma, como movimientos anormales del tórax, ruidos respiratorios, cambios en la coloración de la piel o dificultad para hablar, llorar o toser. Estas manifestaciones deben valorarse de

manera conjunta, puesto que pueden indicar una disminución de la entrada de aire y requerir atención inmediata.

El reconocimiento de las estructuras respiratorias orienta la apertura de la vía aérea, la valoración de la respiración y la aplicación de maniobras de desobstrucción en caso de OVACE. La identificación temprana de los signos de dificultad respiratoria y la actuación oportuna son fundamentales, debido a que estas alteraciones pueden evolucionar rápidamente durante la primera infancia (Ministerio de Salud y Protección Social, 2018).

Además de incorporar el oxígeno necesario para el funcionamiento del organismo, el cuerpo requiere una barrera que lo proteja frente a lesiones, microorganismos y otros agentes externos. Esta función corresponde principalmente a la piel y a sus estructuras asociadas, las cuales conforman el sistema tegumentario.

1.3. Sistema tegumentario

La protección del organismo depende, en gran medida, de la integridad de la piel. Esta estructura actúa como barrera frente a microorganismos, golpes, cambios de temperatura y otros agentes externos. Además, participa en la sensibilidad y en la regulación de la temperatura corporal.

El sistema tegumentario está conformado por la piel y sus estructuras asociadas, como el cabello, las uñas y las glándulas. La piel se organiza en tres capas principales: epidermis, dermis e hipodermis (Tortora y Derrickson, 2021). Durante la primera infancia, es más delgada, sensible y vulnerable, por lo que puede lesionarse con mayor facilidad.

La observación del color, la temperatura y la integridad de la piel permite reconocer alteraciones que requieren protección o atención inmediata. Entre las manifestaciones más frecuentes se encuentran las siguientes:

- **Heridas:** producen una pérdida de continuidad de la piel. Por ejemplo, un raspón durante el juego puede ocasionar dolor, sangrado y riesgo de infección.
- **Quemaduras:** lesionan la piel por acción del calor, la electricidad, sustancias químicas u otros agentes. Por ejemplo, pueden producirse por el contacto accidental con agua caliente.
- **Irritaciones:** generan enrojecimiento, picazón o inflamación por contacto con sustancias o materiales. Por ejemplo, algunos productos de limpieza pueden irritar la piel infantil.
- **Coloración:** comprende cambios como palidez, enrojecimiento o cianosis. Por ejemplo, una tonalidad azulada en los labios puede indicar una alteración respiratoria.

El reconocimiento de estas manifestaciones permite establecer la posible gravedad de la lesión y evitar prácticas que puedan incrementar el daño. En la primera infancia, cualquier cambio significativo debe valorarse teniendo en cuenta su extensión, localización, causa y evolución.

Ante una lesión de la piel, la actuación inicial debe desarrollarse de manera organizada. Para orientar este proceso, se presentan las siguientes acciones generales:

- a) **Verificar la seguridad del entorno:** identificar y controlar, cuando sea posible, el agente que ocasionó la lesión, sin poner en riesgo a la persona afectada ni al primer respondiente.
- b) **Aplicar medidas de bioseguridad:** utilizar los elementos de protección disponibles para evitar el contacto directo con sangre, fluidos corporales o sustancias potencialmente peligrosas.
- c) **Observar la lesión:** reconocer su localización, extensión, profundidad aparente y posibles signos de alarma, sin presionar ni manipular innecesariamente la zona afectada.
- d) **Proporcionar la atención inicial:** limpiar y proteger las heridas superficiales o enfriar las quemaduras térmicas con agua corriente limpia, según el tipo de lesión.
- e) **Solicitar atención especializada:** activar el servicio de emergencias cuando existan sangrado abundante, quemaduras extensas, dificultad respiratoria, alteración de la conciencia u otros signos de gravedad.

Estas acciones contribuyen a proteger la zona afectada, disminuir el riesgo de infección y prevenir complicaciones. No deben aplicarse sustancias caseras, cremas ni otros productos sobre una quemadura, salvo indicación del personal de salud.

Además de proteger al organismo frente a los agentes externos, el cuerpo necesita estructuras que le proporcionen soporte, estabilidad y movimiento. Estas funciones dependen de la acción coordinada de los huesos, los músculos y las articulaciones, componentes del sistema musculoesquelético.

1.4. Sistema musculoesquelético

El movimiento corporal requiere la participación coordinada de diferentes estructuras que proporcionan soporte, estabilidad y protección. Durante la primera infancia, estas estructuras se encuentran en crecimiento y favorecen el desarrollo de habilidades como caminar, correr, saltar y manipular objetos.

El sistema musculoesquelético está constituido por huesos, músculos, articulaciones, ligamentos y tendones. Los huesos brindan soporte y protegen los órganos internos, mientras que los músculos y las articulaciones permiten el movimiento (Tortora y Derrickson, 2021). Aunque los huesos infantiles presentan mayor flexibilidad, las caídas y los golpes pueden ocasionar lesiones.

La valoración inicial permite reconocer alteraciones relacionadas con el dolor, la inflamación, la deformidad o la limitación del movimiento. Las lesiones musculoesqueléticas más frecuentes se describen a continuación:

- **Esguince:** afecta un ligamento por estiramiento o desgarro. Por ejemplo, puede producirse cuando una niña o un niño se tuerce el tobillo durante el juego.
- **Luxación:** ocurre cuando un hueso se desplaza fuera de su articulación. Puede manifestarse mediante dolor intenso, deformidad visible y dificultad para mover la zona.
- **Fractura:** corresponde a la ruptura parcial o total de un hueso. Por ejemplo, puede presentarse después de una caída y causar dolor, inflamación o deformidad.

- **Contusión:** se produce por un golpe que lesiona los tejidos sin romper la piel. Por ejemplo, puede ocasionar dolor, inflamación y cambio de coloración.

La presencia de dolor intenso, deformidad, inflamación progresiva o incapacidad para mover una extremidad puede indicar una lesión que requiere atención especializada. La zona afectada debe mantenerse en reposo y en la posición encontrada, evitando movimientos que puedan agravar el daño.

Cuando se sospecha una lesión musculoesquelética, la atención inicial debe seguir una secuencia organizada y segura:

- a) Comprobar la seguridad del lugar:** verificar que no persistan riesgos asociados con la caída, el golpe o el objeto que produjo la lesión.
- b) Observar la zona afectada:** identificar dolor, inflamación, heridas, deformidad, cambio de coloración o limitación del movimiento, sin forzar la extremidad.
- c) Evitar movimientos innecesarios:** mantener la zona en la posición encontrada y solicitar a la persona afectada que permanezca en reposo.
- d) Inmovilizar cuando sea necesario:** estabilizar la extremidad sin intentar enderezarla ni devolver los huesos o las articulaciones a su posición.
- e) Solicitar atención especializada:** activar el servicio de emergencias ante deformidad, dolor intenso, sangrado, pérdida de sensibilidad o sospecha de lesión en la cabeza, el cuello o la columna.

El manejo inicial busca disminuir el movimiento, evitar nuevas lesiones y facilitar un traslado seguro. No se debe intentar corregir una deformidad ni comprobar una posible fractura mediante movimientos, ya que estas prácticas pueden aumentar el dolor y afectar los tejidos cercanos.

El reconocimiento de las funciones y alteraciones de los sistemas circulatorio, respiratorio, tegumentario y musculoesquelético permite comprender su importancia durante una situación crítica. Esta integración facilita la identificación de signos de alarma y orienta la atención inicial de las emergencias en la primera infancia.

1.5. Relación con la atención de emergencias

Durante una emergencia, los sistemas corporales pueden afectarse de manera simultánea. Una caída, por ejemplo, puede ocasionar una herida, una fractura y una alteración de la circulación. Por esta razón, la valoración no debe limitarse a la lesión visible, sino considerar el estado general de la persona afectada.

La comprensión integrada de los sistemas permite reconocer cambios que pueden comprometer la respiración, la circulación, la integridad de la piel o el movimiento. Esta relación ayuda al primer respondiente a establecer prioridades y a solicitar oportunamente la atención especializada.

La valoración inicial permite identificar los sistemas corporales afectados y establecer las acciones prioritarias de atención. Para ello, se deben observar los signos presentes, relacionarlos con la posible lesión y determinar si existe riesgo para la vida de la niña o el niño.

A continuación, se describen las principales alteraciones:

- a) Circulatorias:** incluyen sangrado abundante, palidez, piel fría, pulso débil o ausencia de respuesta. Estos signos pueden indicar una alteración del flujo sanguíneo. Por ejemplo, ante una herida con hemorragia, se debe aplicar presión directa, comprobar el estado general y solicitar atención especializada para prevenir un posible choque circulatorio.
- b) Respiratorias:** comprenden dificultad para respirar, respiración rápida, lenta o ausente, ruidos anormales y coloración azulada. Estas manifestaciones pueden indicar una alteración de la oxigenación. Por ejemplo, si un alimento obstruye la vía aérea, se debe aplicar de inmediato la técnica correspondiente para atender la obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño.
- c) Tegumentarias:** incluyen heridas, quemaduras, irritaciones y cambios en la coloración o la temperatura de la piel. Estas lesiones pueden afectar la protección del organismo. Por ejemplo, ante una quemadura extensa, se debe enfriar la zona con agua corriente, cubrirla con material limpio y evitar la aplicación de sustancias caseras.
- d) Musculoesqueléticas:** se manifiestan mediante dolor, inflamación, deformidad o limitación del movimiento y pueden afectar el soporte corporal. Por ejemplo, después de una caída que ocasione una posible fractura, se debe inmovilizar la zona, evitar movimientos innecesarios y realizar un traslado seguro, sin intentar acomodar el hueso afectado.

El reconocimiento conjunto de estos signos permite comprender que una lesión puede afectar varios sistemas corporales al mismo tiempo. Por esta razón, la atención debe priorizar las alteraciones que comprometan la conciencia, la respiración, la circulación o produzcan una hemorragia grave.

Ante una situación de emergencia, la actuación inicial puede organizarse mediante la siguiente secuencia:

- a) Proteger:** verificar la seguridad del lugar y evitar que la persona afectada, el primer respondiente u otras personas se expongan a nuevos riesgos.
- b) Valorar:** comprobar la respuesta, la respiración, la presencia de hemorragias graves y otros signos visibles que puedan indicar una situación crítica.
- c) Alertar:** comunicarse con el servicio de emergencias y proporcionar información clara sobre el lugar, la situación y el estado de la persona afectada.
- d) Atender:** aplicar únicamente las técnicas de primeros auxilios conocidas, sin realizar procedimientos que superen la preparación del primer respondiente.
- e) Acompañar:** observar los cambios en el estado de la persona, conservar la calma y permanecer a su lado hasta la llegada del personal especializado.

Esta secuencia favorece una respuesta segura, ordenada y centrada en las necesidades prioritarias. En la primera infancia, la observación permanente es fundamental, ya que el estado de una niña o un niño puede cambiar rápidamente durante una emergencia.

La comprensión de la anatomía y la fisiología básicas proporciona los fundamentos para reconocer posibles alteraciones corporales. Estos conocimientos facilitan la evaluación inicial de la persona lesionada, permiten identificar su estado general y ayudan a establecer las prioridades de atención.

2. Evaluación inicial del lesionado

La evaluación inicial permite reconocer de manera rápida y organizada el estado general de la persona lesionada. Su propósito es identificar las alteraciones que pueden comprometer la vida, establecer prioridades de atención y determinar si se requiere activar inmediatamente el servicio de emergencias.

En la primera infancia, esta valoración exige observar cuidadosamente las respuestas de la niña o el niño, debido a que su estado puede cambiar en poco tiempo. Además de comprobar el nivel de conciencia, la respiración y el pulso, se deben identificar hemorragias, cambios en la coloración de la piel, movimientos inusuales y otras manifestaciones de alarma.

Para orientar este proceso, se consideran cuatro aspectos fundamentales:

- a) Nivel de conciencia:** permite identificar si la niña o el niño permanece alerta, responde a la voz, reacciona ante otros estímulos o no presenta respuesta.
- b) Respiración:** permite comprobar la entrada y salida del aire, así como observar la frecuencia, el ritmo, los ruidos anormales y el esfuerzo realizado para respirar.
- c) Pulso:** permite reconocer la actividad cardíaca y el estado de la circulación mediante la comprobación de su presencia, frecuencia, ritmo e intensidad.
- d) Signos de alarma:** corresponden a manifestaciones que pueden indicar una condición grave, como dificultad respiratoria intensa, convulsiones, sangrado abundante, coloración azulada o pérdida de la conciencia.

Estos aspectos deben valorarse de manera conjunta, ya que una alteración puede estar relacionada con otras manifestaciones. Por ejemplo, la ausencia de respuesta acompañada de una respiración anormal requiere una actuación inmediata. Para realizar la evaluación inicial de forma segura y ordenada, se proponen los siguientes pasos:

- a)** Comprobar que el lugar no presente riesgos para la persona lesionada, quien brinda la primera respuesta u otras personas.
- b)** Hablarle a la persona y observar si responde a la voz, al contacto o a otros estímulos.
- c)** Observar los movimientos del tórax y el abdomen, escuchar posibles sonidos y reconocer si existe dificultad para respirar.
- d)** Identificar su presencia y observar sus principales características, siempre que se cuente con la preparación necesaria.
- e)** Buscar hemorragias graves, convulsiones, cambios en la coloración, lesiones visibles o un deterioro repentino del estado general.
- f)** Activar el servicio de emergencias cuando se identifique una alteración grave o exista riesgo para la vida.
- g)** Acompañar a la persona lesionada y observar cualquier cambio hasta la llegada del personal especializado.

El seguimiento de estos pasos permite realizar una valoración organizada, reconocer oportunamente posibles alteraciones y evitar acciones que puedan agravar la situación. Esta primera observación proporciona información esencial para profundizar en el estado de la persona lesionada, comenzando por la valoración del nivel de conciencia.

2.1. Nivel de conciencia

La respuesta de una niña o un niño ante la voz, el contacto y otros estímulos permite reconocer posibles cambios en su estado general. Esta observación debe compararse con su comportamiento habitual, debido a que cada persona puede reaccionar de manera diferente según su edad, condición de salud y circunstancias de la lesión.

La somnolencia inusual, la desorientación o la ausencia de respuesta pueden indicar un deterioro que requiere atención inmediata. Por ello, también es necesario observar la respiración, la coloración de la piel y la capacidad para interactuar, seguir indicaciones o realizar movimientos habituales.

Para llevar a cabo esta valoración de forma rápida y organizada, se utiliza la escala AVPU. Esta herramienta clasifica el nivel de conciencia de acuerdo con cuatro tipos de respuesta: alerta, respuesta verbal, respuesta al dolor y ausencia de respuesta.

A continuación, la siguiente figura presenta los cuatro niveles que conforman la escala AVPU y las respuestas asociadas a cada uno.

Figura 2. Escala AVPU para valorar el nivel de conciencia



Escala AVPU para valorar el nivel de conciencia

- **Alerta:** la persona está consciente, responde adecuadamente al entorno, puede interactuar y seguir indicaciones.
- **Respuesta verbal:** la persona no está completamente alerta, pero responde cuando se le habla o se le llama.
- **Respuesta al dolor:** la persona no responde a estímulos verbales, pero reacciona ante estímulos dolorosos.
- **No responde:** la persona no presenta respuesta ante ningún estímulo, lo que indica una condición crítica.

Para dar continuidad a la evaluación inicial, se deben observar los movimientos del tórax y el abdomen, así como la frecuencia y el ritmo respiratorios. También es

importante identificar sonidos anormales o señales de esfuerzo al respirar. Estos aspectos permiten reconocer posibles alteraciones y orientar adecuadamente la valoración de la respiración.

2.2. Valoración de la respiración

Una vez valorado el nivel de conciencia, es necesario comprobar cómo respira la niña o el niño. Esta observación permite reconocer si el aire ingresa y sale adecuadamente, así como detectar cambios que puedan afectar la oxigenación. Debido a las características propias de la primera infancia, cualquier alteración respiratoria requiere una valoración cuidadosa y oportuna.

Para realizar esta valoración, se deben observar los movimientos del tórax y el abdomen, contar las respiraciones durante un minuto e identificar el ritmo, la profundidad, los sonidos y el esfuerzo respiratorio. La observación debe efectuarse sin causar agitación, debido a que el llanto, el miedo, la actividad física o la fiebre pueden modificar temporalmente la forma de respirar.

Los principales aspectos que deben tenerse en cuenta son los siguientes:

- **Frecuencia respiratoria:** corresponde al número de respiraciones realizadas durante un minuto. Su valoración permite reconocer si la respiración se mantiene dentro de las características esperadas para la edad o presenta cambios que requieren atención.
- **Ritmo respiratorio:** indica si las respiraciones se producen de manera regular o irregular. Se debe observar si los intervalos entre cada respiración

son semejantes o si se presentan pausas, cambios repentinos o movimientos desorganizados.

- **Profundidad respiratoria:** permite identificar la cantidad de aire movilizada durante cada respiración. Puede reconocerse mediante la amplitud de los movimientos del tórax y el abdomen, los cuales pueden ser normales, superficiales o más profundos de lo habitual.
- **Sonidos respiratorios:** corresponden a los ruidos que acompañan la entrada y salida del aire. La presencia de silbidos, ronquidos, quejidos u otros sonidos inusuales puede relacionarse con una dificultad en el paso del aire.
- **Esfuerzo respiratorio:** comprende las manifestaciones que evidencian dificultad para respirar. Entre ellas se encuentran el hundimiento de la piel entre las costillas, el movimiento exagerado del abdomen, la apertura de las fosas nasales y el uso marcado de los músculos del cuello.

La valoración conjunta de estos aspectos permite reconocer cómo se realiza la respiración y facilita la identificación de cambios relevantes. No debe interpretarse una característica de manera aislada, pues la edad, el llanto, la fiebre, la actividad física y el estado emocional pueden modificar temporalmente el patrón respiratorio.

En la primera infancia, las alteraciones respiratorias pueden presentarse de distintas formas según su causa y evolución. Por ello, no basta con comprobar que existe respiración; también se deben analizar sus características para determinar si la ventilación parece adecuada o si requiere una intervención oportuna.

La comparación de los patrones observados facilita la toma de decisiones durante la atención inicial. La siguiente tabla presenta los principales tipos de respiración, sus características y las acciones generales que deben considerarse.

Tabla 1. Tipos de respiración y acciones iniciales

Tipo de respiración	Características observables	Acción inicial
Respiración normal	Presenta movimientos regulares del tórax y el abdomen, sin ruidos anormales ni esfuerzo evidente.	Mantener la observación y comprobar periódicamente que no se presentan cambios.
Respiración rápida	Se evidencia un aumento del número de respiraciones en comparación con el estado habitual de la niña o el niño.	Mantener en reposo, evitar la agitación y vigilar la evolución de la respiración.
Respiración lenta	Presenta una disminución evidente del número de respiraciones o pausas más prolongadas de lo habitual.	Solicitar atención especializada y observar permanentemente el nivel de respuesta.

Tipo de respiración	Características observables	Acción inicial
Respiración irregular	Alterna respiraciones rápidas, lentas, superficiales o pausas sin un patrón constante.	Mantener la vigilancia y solicitar ayuda especializada si el cambio persiste o empeora.
Respiración con esfuerzo	Se observa hundimiento entre las costillas, apertura de las fosas nasales, movimientos exagerados o uso de los músculos del cuello.	Facilitar una posición cómoda, evitar movimientos innecesarios y activar el servicio de emergencias.
Respiración ruidosa	Presenta silbidos, ronquidos, quejidos u otros sonidos inusuales durante la entrada o salida del aire.	Verificar que la vía aérea permanezca despejada y solicitar valoración especializada.
Respiración ausente	No se observan movimientos del tórax ni del abdomen y no se percibe entrada o salida de aire.	Activar inmediatamente el servicio de emergencias e iniciar las maniobras correspondientes, si se cuenta con la preparación necesaria.

Las características respiratorias pueden modificarse en poco tiempo; por ello, la observación debe mantenerse durante toda la atención inicial. Si la respiración es ausente, irregular o se realiza con un esfuerzo evidente, se debe solicitar ayuda especializada y actuar únicamente de acuerdo con la preparación recibida.

La respiración aporta información esencial sobre el funcionamiento del organismo; sin embargo, también es necesario comprobar cómo se mantiene la circulación. Esta valoración se complementa con la identificación del pulso y de sus principales características.

2.3. Valoración del pulso

Durante una emergencia, la observación del pulso ayuda a reconocer cómo se encuentra la actividad cardíaca y la circulación sanguínea. En la primera infancia, esta valoración debe realizarse con precisión, porque la frecuencia cardíaca suele ser mayor y cualquier alteración puede evolucionar rápidamente.

Para realizar esta valoración de manera organizada, se recomienda seguir la siguiente secuencia:

- a) Localizar la arteria:** ubicar la arteria braquial en lactantes o la arteria carótida en niñas y niños mayores.
- b) Palpar suavemente:** colocar las yemas de los dedos índice y medio sobre la arteria, sin ejercer una presión excesiva.
- c) Comprobar la presencia:** verificar si el pulso se percibe con claridad durante un tiempo máximo de 10 segundos.

- d) Observar sus características:** identificar la frecuencia, el ritmo y la intensidad del pulso, teniendo en cuenta el estado general de la niña o el niño.
- e) Relacionar los hallazgos:** valorar el pulso junto con la respiración, la coloración de la piel, el nivel de conciencia y otros signos observados.

Esta secuencia facilita la identificación de posibles alteraciones circulatorias y orienta la necesidad de solicitar atención especializada. Un pulso débil, irregular o ausente puede estar acompañado de otros signos de deterioro que requieren una actuación inmediata.

Una vez comprobada la presencia del pulso, se deben observar sus características y relacionarlas con el estado general de la niña o el niño. La siguiente tabla sintetiza los principales hallazgos, su posible interpretación y la atención inicial correspondiente.

Tabla 2. Valoración del pulso en la evaluación inicial

Pulso	Características	Posible interpretación	Atención inicial
Normal	Presenta una frecuencia y un ritmo acordes con el estado general.	La circulación se encuentra conservada.	Continuar con la valoración y observar posibles cambios.
Rápido	La frecuencia se encuentra aumentada.	Puede relacionarse con dolor, fiebre,	Observar otros signos y vigilar la evolución.

Pulso	Características	Posible interpretación	Atención inicial
		temor o pérdida de líquidos.	
Lento	La frecuencia se encuentra disminuida.	Puede indicar un compromiso respiratorio, cardíaco o neurológico.	Solicitar atención especializada y vigilar el estado general.
Débil	El pulso es difícil de percibir.	Puede existir una circulación insuficiente.	Activar el servicio de emergencias y observar otros signos.
Ausente	No se percibe durante la evaluación realizada por una persona capacitada.	Puede indicar un paro cardiorrespiratorio.	Iniciar la RCP según el protocolo establecido.

De acuerdo con la información presentada, las características del pulso deben interpretarse junto con la respiración, el nivel de conciencia, la coloración y la temperatura de la piel. Esta valoración integral permite reconocer oportunamente un posible compromiso circulatorio y determinar la necesidad de atención inmediata.

Además de los cambios en el pulso, pueden presentarse otras manifestaciones que indiquen un deterioro del estado general. Por esta razón, la evaluación inicial continúa con la identificación de los signos de alarma que requieren una actuación oportuna.

2.4. Identificación de signos de alarma

El estado de una niña o un niño puede cambiar rápidamente ante una lesión o alteración de la salud. Por esta razón, es necesario observar su respiración, nivel de conciencia, coloración de la piel, comportamiento y respuesta a los estímulos. Estos elementos permiten reconocer la gravedad de la situación y establecer prioridades durante la atención inicial.

Según las manifestaciones observadas y la respuesta requerida, los signos pueden organizarse en tres niveles:

A. Observación (Seguimiento)

- **Irritabilidad leve:** cambio moderado en el comportamiento que requiere acompañamiento y seguimiento.
- **Malestar general:** presencia de incomodidad, cansancio o disminución temporal del estado habitual.

- **Lesiones leves:** heridas superficiales, golpes menores o molestias que no comprometen el estado general.
- **Cambios leves en la actividad:** disminución moderada del juego, el movimiento o la interacción.

B. Alerta (Valoración oportuna)

- **Respiración rápida o irregular:** cambio en la frecuencia o el ritmo respiratorio que requiere vigilancia.
- **Dolor intenso:** molestia que causa llanto persistente, limita el movimiento o altera el comportamiento.
- **Fiebre persistente:** aumento de la temperatura que se mantiene o se acompaña de decaimiento.
- **Debilidad o decaimiento:** disminución evidente de la energía, la actividad o la capacidad de respuesta.
- **Cambios importantes en el comportamiento:** somnolencia inusual, irritabilidad intensa, confusión o dificultad para interactuar.

C. Grave (Atención inmediata)

- **Ausencia de respiración:** falta de movimientos respiratorios y de entrada o salida de aire.
- **Dificultad respiratoria intensa:** esfuerzo evidente para respirar, hundimiento del pecho, ruidos anormales o coloración azulada.
- **Pérdida de la conciencia:** ausencia de respuesta ante la voz o los estímulos.
- **Convulsiones:** movimientos involuntarios, rigidez corporal o pérdida repentina de la respuesta.

- **Sangrado abundante:** pérdida de sangre que no se controla mediante presión directa.
- **Cianosis:** coloración azulada o violácea en los labios, la piel o las uñas.

Esta clasificación orienta la observación y ayuda a reconocer cuándo se requiere seguimiento, valoración o atención inmediata. Los signos deben interpretarse de manera conjunta, ya que el estado general puede cambiar rápidamente y exigir la activación del servicio de emergencias.

Una vez identificadas las manifestaciones que pueden comprometer la vida, es necesario conocer las acciones destinadas a mantener la respiración y la circulación. En el siguiente apartado, se presentan los procedimientos de soporte vital básico aplicados en la primera infancia.

3. Soporte vital básico en primera infancia

El soporte vital básico corresponde al conjunto de acciones inmediatas orientadas a mantener la oxigenación y la circulación en una persona que presenta una alteración grave de sus funciones vitales. Estas intervenciones buscan preservar la vida hasta la llegada de atención especializada, mediante la aplicación de técnicas estandarizadas y seguras.

En la primera infancia, el soporte vital básico adquiere especial relevancia debido a la mayor vulnerabilidad de niñas y niños frente a eventos como la obstrucción de la vía aérea, la insuficiencia respiratoria y el paro cardiorrespiratorio. Estas situaciones pueden evolucionar rápidamente, por lo que requieren una intervención oportuna y adecuada por parte del primer respondiente.

La atención inicial se basa en la valoración de la niña o del niño y en la aplicación de técnicas específicas, de acuerdo con la emergencia identificada:

- Reanimación cardiopulmonar.
- Manejo de la obstrucción de la vía aérea.
- Uso del desfibrilador externo automático.

La aplicación correcta y oportuna de estas técnicas contribuye a mantener o recuperar la respiración y la circulación, mientras llega la atención especializada. Por esta razón, deben realizarse de manera segura y de acuerdo con la edad y las condiciones de la niña o del niño.

A continuación, se explica la reanimación cardiopulmonar y su aplicación según la edad de la niña o del niño, teniendo en cuenta sus características anatómicas y fisiológicas, así como las condiciones de seguridad necesarias durante la atención.

3.1. RCP en lactantes

La reanimación cardiopulmonar (RCP) en lactantes es una técnica de soporte vital básico que se aplica cuando el lactante no responde y no respira normalmente o solo jadea. Su finalidad es mantener temporalmente la circulación sanguínea y el aporte de oxígeno a los órganos vitales mientras llega la atención especializada. Durante el primer año de vida, el paro cardiorrespiratorio suele estar relacionado con alteraciones respiratorias; por ello, se requiere una actuación rápida, segura y organizada (American Heart Association, 2020).

Antes de iniciar la RCP, se debe verificar la seguridad del entorno y valorar la respuesta y la respiración del lactante. Si no responde y no respira normalmente, se debe solicitar ayuda, activar el sistema de emergencias mediante la línea 123 e iniciar las maniobras de reanimación, de acuerdo con la capacitación recibida.

Para realizar el procedimiento, se deben seguir estas acciones:

- a) **Verificar la seguridad:** comprobar que el lugar no represente peligro para el lactante ni para quien brinda la atención.
- b) **Valorar la respuesta:** estimular suavemente al lactante y observar si responde mediante movimientos, sonidos o gestos.
- c) **Observar la respiración:** verificar si respira normalmente o solo jadea, sin prolongar innecesariamente la valoración.
- d) **Solicitar ayuda:** pedir apoyo a las personas cercanas y activar el sistema de emergencias mediante la línea 123.
- e) **Ubicar al lactante:** colocarlo boca arriba sobre una superficie firme y plana para facilitar las maniobras.

- f) **Iniciar las compresiones:** comprimir el centro del pecho, sobre el esternón, con el talón de una mano o mediante la técnica de los dos pulgares con las manos rodeando el tórax.
- g) **Aplicar la profundidad adecuada:** comprimir aproximadamente un tercio del diámetro anteroposterior del tórax, equivalente a unos 4 cm.
- h) **Mantener el ritmo:** realizar entre 100 y 120 compresiones por minuto, permitir la expansión completa del tórax y reducir al mínimo las interrupciones.
- i) **Combinar compresiones y ventilaciones:** realizar ciclos de 30 compresiones y 2 ventilaciones cuando participa un solo reanimador, o de 15 compresiones y 2 ventilaciones cuando intervienen dos reanimadores capacitados.
- j) **Continuar las maniobras:** mantener la RCP hasta que el lactante muestre signos de respuesta, llegue el personal especializado, el entorno deje de ser seguro o quien brinda la atención no pueda continuar.

La aplicación ordenada de estas acciones contribuye a mantener la circulación y el aporte de oxígeno durante una emergencia. Las maniobras deben realizarse con precaución, sin ejercer una fuerza excesiva y conforme a los protocolos vigentes y la capacitación recibida.

Después de reconocer la técnica de RCP en lactantes, es necesario comprender otra situación de emergencia frecuente durante la primera infancia: la obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño. A diferencia del paro cardiorrespiratorio, esta condición puede presentarse mientras la niña o el niño está consciente, por lo que exige señales de identificación y maniobras diferentes. Por esta razón, a continuación se aborda la

obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño (OVACE), sus manifestaciones y las acciones seguras para atenderla.

3.2. Obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño (OVACE)

La obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño (OVACE) es una emergencia que ocurre cuando un alimento u objeto bloquea de manera parcial o total el paso del aire hacia los pulmones. En lactantes, niñas y niños, esta situación puede evolucionar rápidamente; por ello, es fundamental reconocer las señales de alerta y actuar de manera oportuna y segura.

La obstrucción puede presentarse mientras se consumen alimentos o cuando se introducen objetos pequeños en la boca. El riesgo aumenta con alimentos duros, redondos o difíciles de masticar, así como con monedas, botones, piezas de juguetes y otros elementos que se encuentran al alcance de la población infantil.

A. Reconocimiento de la obstrucción

Las manifestaciones dependen de si el paso del aire está bloqueado de forma parcial o total:

- **Obstrucción parcial:** la niña o el niño puede toser con fuerza, emitir sonidos, respirar y responder. En este caso, se debe permitir que continúe tosiendo, observar su evolución y evitar maniobras innecesarias.
- **Obstrucción total:** la niña o el niño no puede hablar, llorar, toser eficazmente ni respirar. También puede llevarse las manos al cuello,

presentar coloración azulada alrededor de los labios o perder el conocimiento.

Reconocer el tipo de obstrucción permite seleccionar la actuación adecuada. No se deben introducir los dedos en la boca ni intentar retirar el objeto cuando no sea visible, ya que podría desplazarse hacia una zona más profunda.

B. Actuación ante una obstrucción en lactantes

Si el lactante está consciente y presenta una obstrucción total, se deben aplicar las siguientes acciones:

- **Solicitar ayuda:** pedir apoyo y activar el sistema de emergencias mediante la línea 123.
- **Ubicar al lactante:** colocarlo boca abajo sobre el antebrazo o el muslo, con la cabeza más baja que el pecho y sostenida de manera segura.
- **Aplicar golpes en la espalda:** realizar cinco golpes firmes entre los omóplatos con el talón de la mano.
- **Girar al lactante:** colocarlo boca arriba, manteniendo la cabeza más baja que el pecho.
- **Realizar compresiones torácicas:** aplicar cinco compresiones en el centro del pecho, sobre el esternón.
- **Repetir la secuencia:** alternar cinco golpes en la espalda y cinco compresiones torácicas hasta que el objeto sea expulsado, el lactante respire o pierda la respuesta.

No se deben realizar compresiones abdominales en lactantes, debido al riesgo de causar lesiones en los órganos internos.

C. Actuación ante una obstrucción en niñas y niños

Si la niña o el niño está consciente y no puede respirar, hablar, llorar o toser eficazmente, se deben aplicar estas acciones:

- **Solicitar ayuda:** activar el sistema de emergencias mediante la línea 123.
- **Ubicarse detrás:** colocarse detrás de la niña o del niño y rodear su cintura con los brazos.
- **Posicionar las manos:** formar un puño y ubicarlo por encima del ombligo y por debajo del esternón; luego, sujetarlo con la otra mano.
- **Aplicar compresiones abdominales:** realizar impulsos rápidos hacia adentro y hacia arriba.
- **Continuar la atención:** repetir las compresiones hasta que el objeto sea expulsado, la niña o el niño vuelva a respirar o pierda la respuesta.

Las maniobras deben ajustarse al tamaño y a las condiciones físicas de la niña o del niño, evitando aplicar una fuerza desproporcionada.

Después de reconocer las acciones para atender una obstrucción de la vía aérea, es importante abordar el uso del desfibrilador externo automático como apoyo durante la reanimación cardiopulmonar. En el siguiente apartado, se explica su función y las principales recomendaciones para utilizarlo de manera segura en lactantes, niñas y niños.

3.3. Uso del desfibrilador externo automático (DEA)

El desfibrilador externo automático (DEA) es un dispositivo portátil que analiza el ritmo cardíaco y determina si es necesario aplicar una descarga eléctrica. Su uso durante un paro cardiorrespiratorio complementa la reanimación cardiopulmonar (RCP), pero no reemplaza las compresiones ni las ventilaciones.

En lactantes, niñas y niños, el DEA debe utilizarse tan pronto como esté disponible. Para menores de ocho años, se emplean preferiblemente parches pediátricos o un sistema reductor de energía. Si estos elementos no están disponibles, puede utilizarse un DEA con parches para personas adultas, siguiendo las instrucciones del dispositivo.

Mientras una persona realiza la RCP, otra debe activar el sistema de emergencias mediante la línea 123 y buscar el DEA. Para utilizarlo de manera organizada y segura, se deben seguir estas acciones:

- **Encender el DEA:** activar el dispositivo y escuchar atentamente las instrucciones visuales o de voz.
- **Descubrir el pecho:** retirar las prendas que impidan la colocación de los parches y secar la piel si se encuentra húmeda.
- **Seleccionar los parches:** utilizar parches pediátricos o un sistema reductor de energía cuando estén disponibles para lactantes y menores de ocho años.
- **Colocar los parches:** adherirlos sobre el pecho desnudo, de acuerdo con las imágenes indicadas en el dispositivo. Si los parches pueden tocarse entre sí, se debe colocar uno en el centro del pecho y otro en la espalda.

- **Permitir el análisis:** suspender momentáneamente las compresiones y verificar que ninguna persona toque al lactante, la niña o el niño mientras el DEA analiza el ritmo cardíaco.
- **Aplicar la descarga:** si el dispositivo la recomienda, comprobar que nadie esté en contacto con la persona y seguir la indicación para administrarla.
- **Reanudar la RCP:** reiniciar inmediatamente las compresiones y las ventilaciones después de la descarga o cuando el DEA indique que esta no es necesaria.
- **Seguir las instrucciones:** continuar la RCP y atender las indicaciones del dispositivo hasta que se evidencien signos de respuesta o llegue el personal especializado.

Durante el uso del DEA, se deben tener en cuenta las siguientes precauciones:

- A. No colocar los parches sobre ropa, piel mojada ni objetos metálicos.
- B. No permitir que los parches se toquen o se superpongan.
- C. No tocar al lactante, la niña o el niño durante el análisis ni al aplicar la descarga.
- D. No retirar los parches ni apagar el dispositivo mientras continúa la atención.
- E. Reducir al mínimo las interrupciones de las compresiones torácicas.

El uso oportuno del DEA, combinado con una RCP de calidad, fortalece la respuesta ante un paro cardiorrespiratorio. Mantener la calma, seguir las instrucciones del dispositivo y continuar las maniobras contribuye a brindar una atención inicial segura mientras llega el personal especializado.

Después de reconocer las acciones de soporte vital básico, es necesario abordar otras situaciones que también pueden afectar la salud y la integridad de lactantes, niñas y niños. En el siguiente apartado, se presentan las medidas de atención inicial ante lesiones, traumatismos y situaciones que requieren una movilización segura.

4. Lesiones, traumatismos y movilización

Este eje temático aborda la atención inicial de heridas, hemorragias y quemaduras; el manejo de lesiones osteomusculares y traumatismos; y las técnicas para movilizar y trasladar de manera segura a la niña o al niño que presenta una lesión. Según las características del evento, estos procedimientos pueden complementarse para brindar una respuesta organizada y prevenir complicaciones.

Ante estas situaciones, el primer respondiente debe conservar la calma, identificar el tipo de lesión y aplicar las medidas iniciales pertinentes. Una actuación oportuna contribuye a evitar el agravamiento de la condición de la niña o del niño mientras se gestiona la ayuda necesaria.

Asimismo, es fundamental valorar el estado general de la niña o del niño, observar la zona afectada y evitar movimientos que puedan agravar la lesión. Esta valoración permite reconocer señales de alarma y determinar la necesidad de recibir atención especializada.

Estas situaciones pueden presentarse con frecuencia en los entornos cotidianos de la primera infancia. Algunos ejemplos son los siguientes:

- **Caídas durante el juego:** pueden ocurrir en el parque o en el patio de un hogar comunitario y ocasionar heridas, golpes o lesiones que requieren valoración inicial.
- **Contacto con líquidos calientes:** puede producir quemaduras en la cocina u otros espacios del hogar y requiere una actuación inmediata para disminuir el daño.

- **Torceduras durante las actividades recreativas:** pueden afectar las articulaciones y exigir la inmovilización de la zona lesionada y un traslado seguro para evitar complicaciones.

Reconocer estos eventos permite identificar los posibles riesgos y aplicar las medidas iniciales correspondientes. En el siguiente apartado, se presentan las características de las heridas, las hemorragias y las quemaduras, junto con las acciones básicas para brindar una atención segura.

4.1. Atención de lesiones en primeros auxilios

Las heridas, las hemorragias y las quemaduras pueden afectar la piel y otros tejidos. Reconocer sus características permite brindar una atención inicial segura, prevenir complicaciones y solicitar ayuda especializada cuando sea necesario.

Las principales lesiones y sus medidas de atención inicial son las siguientes:

- a) Heridas:** son lesiones que afectan la piel o los tejidos y pueden producir cortes, raspaduras, dolor o sangrado. Por ejemplo, una niña puede rasparse la rodilla al caer en el parque. Se debe limpiar la zona con agua, cubrirla con una gasa o material limpio y evitar su manipulación. Si la herida es profunda, contiene un objeto incrustado o continúa sangrando, se debe solicitar atención médica.
- b) Hemorragias:** corresponden a la pérdida de sangre ocasionada por la ruptura de uno o varios vasos sanguíneos. Por ejemplo, un niño puede presentar un sangrado abundante después de cortarse con un objeto afilado. Se debe ejercer presión directa sobre la herida con una gasa o tela

limpia. Si existe un objeto incrustado, no debe retirarse; la presión se aplica alrededor de este.

- c) **Quemaduras:** son lesiones causadas por el calor, las sustancias químicas, la electricidad o la radiación. Por ejemplo, un lactante puede quemarse al entrar en contacto con un líquido caliente. Se debe retirar la fuente que ocasionó la lesión y enfriar la zona con agua corriente fresca durante 20 minutos. No se deben aplicar hielo, cremas ni remedios caseros, ni romper las ampollas. Posteriormente, la zona se cubre suavemente con una gasa o material limpio.

Durante la atención, se debe conservar la calma y observar señales de alarma, como sangrado que no se detiene, dolor intenso, dificultad para respirar, pérdida de respuesta o quemaduras extensas. Ante estas manifestaciones, se debe activar el sistema de emergencias mediante la línea 123.

La aplicación adecuada de estas medidas contribuye a controlar la lesión y prevenir complicaciones. En el siguiente apartado, se presentan las acciones iniciales para reconocer y manejar las lesiones osteomusculares ocasionadas por caídas, golpes u otros traumatismos.

4.2. Manejo de lesiones osteomusculares

El manejo de lesiones en la primera infancia comprende las acciones orientadas a estabilizar, proteger y evitar el agravamiento de lesiones que comprometen estructuras como huesos, articulaciones, tejidos blandos y sistema neurológico. Estas lesiones pueden derivarse de caídas, golpes, accidentes o situaciones de riesgo en el entorno,

siendo frecuentes en esta etapa del desarrollo (Organización Mundial de la Salud, 2020).

La intervención del primer respondiente debe centrarse en la identificación de signos de gravedad, la limitación del movimiento, la protección de la zona afectada y la preparación para un traslado seguro, evitando maniobras que puedan generar daño adicional. La actuación oportuna permite disminuir complicaciones y favorecer la recuperación de la niña o del niño.

Para facilitar la comprensión y orientar la toma de decisiones, la siguiente tabla presenta las principales lesiones osteomusculares y traumáticas, su definición, los signos principales, el manejo inicial y las acciones que deben evitarse en cada caso.

Tabla 3. Manejo inicial de esguinces, luxaciones, fracturas y trauma

Tipo de lesión	Definición	Signos principales	Manejo inicial	Acción que debe evitarse
Esguince	Lesión de los ligamentos causada por un estiramiento o desgarro.	Dolor, inflamación y dificultad para mover o apoyar la articulación.	Mantener la zona en reposo e inmovilizarla para evitar el agravamiento de la lesión.	No masajear ni forzar el movimiento de la articulación.

Tipo de lesión	Definición	Signos principales	Manejo inicial	Acción que debe evitarse
Luxación	Desplazamiento de un hueso fuera de su posición normal en una articulación.	Dolor intenso, deformidad visible e imposibilidad para mover la articulación.	Inmovilizar la zona en la posición encontrada y solicitar atención médica.	No recolocar el hueso ni corregir la deformidad.
Fractura	Ruptura parcial o total de un hueso.	Dolor intenso, inflamación, deformidad y dificultad para mover la zona afectada.	Inmovilizar la extremidad, evitar movimientos innecesarios y gestionar el traslado a un servicio de salud.	No enderezar la extremidad ni presionar directamente sobre el hueso lesionado.
Trauma craneoencefálico	Lesión en la cabeza que puede	Pérdida de conciencia, vómito, somnolencia,	Mantener a la niña o al niño en reposo,	No moverlo ni suministrarle alimentos, bebidas o

Tipo de lesión	Definición	Signos principales	Manejo inicial	Acción que debe evitarse
	comprometer el cerebro.	irritabilidad o cambios en el comportamiento .	vigilar su respuesta y activar el sistema de emergencias.	medicamentos .
Traumatismo cervical	Lesión en la región del cuello que puede comprometer la médula espinal.	Dolor, limitación del movimiento, pérdida de sensibilidad o alteraciones en las extremidades.	Mantener alineadas la cabeza y el cuello, evitar la movilización y solicitar atención especializada .	No girar, levantar ni sentar a la niña o al niño.

Las medidas descritas permiten proteger la zona afectada mientras llega la atención especializada. Durante la valoración, se debe evitar cualquier maniobra que aumente el dolor o pueda agravar la lesión.

Además del manejo específico de cada lesión, se deben considerar las siguientes recomendaciones generales:

- **Conservar la calma:** brindar seguridad a la niña o al niño y explicarle, con palabras sencillas, que recibirá ayuda.
- **Evitar movimientos innecesarios:** mantener la zona lesionada en la posición encontrada y no intentar corregir deformidades.
- **Inmovilizar la lesión:** utilizar elementos adecuados para limitar el movimiento, sin ejercer una presión excesiva ni afectar la circulación.
- **Observar las señales de alarma:** identificar dolor intenso, deformidad, pérdida de conciencia, vómito persistente, dificultad para respirar o alteraciones del movimiento.
- **Solicitar atención especializada:** activar el sistema de emergencias mediante la línea 123 cuando se presenten signos de gravedad.

La aplicación adecuada de estas recomendaciones ayuda a prevenir complicaciones y protege a la niña o al niño mientras recibe atención especializada. No se deben enderezar extremidades, recolocar articulaciones ni efectuar traslados innecesarios.

Después de reconocer el manejo inicial de las lesiones osteomusculares, es necesario comprender cómo actuar ante otros traumatismos que pueden comprometer diferentes partes del cuerpo. En el siguiente apartado, se presentan las medidas correspondientes.

4.3. Manejo de traumas

El manejo de traumas en la primera infancia reúne las acciones iniciales destinadas a atender lesiones causadas por caídas, golpes, accidentes u otras fuerzas externas. Estas situaciones pueden afectar distintas partes del cuerpo y requieren una intervención oportuna para disminuir el riesgo de agravamiento y prevenir posibles complicaciones.

Debido a las características físicas propias de esta etapa, las niñas y los niños pueden presentar mayor vulnerabilidad ante algunas lesiones. Por ello, la atención debe realizarse con cuidado, evitando movimientos innecesarios y observando permanentemente cualquier cambio en su estado general.

El primer respondiente debe identificar el tipo de trauma, valorar la gravedad de la lesión y actuar de manera segura, priorizando la inmovilización, la protección de la zona afectada y la estabilidad de la niña o del niño. La intervención debe evitar movimientos innecesarios que puedan agravar el daño, especialmente en casos de compromiso de cabeza, cuello o columna.

Para orientar una atención segura, es necesario reconocer las características de la lesión y la zona del cuerpo comprometida. En la primera infancia, los golpes o las caídas pueden afectar especialmente la cabeza y el cuello; por ello, resulta fundamental diferenciar los tipos de trauma, reconocer sus signos de alarma y aplicar las medidas iniciales correspondientes, sin realizar movimientos que puedan agravar el daño. Con este propósito, se presentan las características y las medidas de atención inicial de los siguientes traumas:

- **Trauma craneoencefálico:** corresponde a una lesión en la cabeza que puede afectar el cerebro y alterar el estado general de la niña o el niño. Por ejemplo, después de una caída desde una cama, si presenta vómito repetido, somnolencia, convulsiones o cambios en el comportamiento, se deben evitar movimientos bruscos, vigilar su estado y solicitar atención especializada.
- **Trauma cervical:** corresponde a una lesión que puede comprometer las estructuras del cuello y la parte superior de la columna vertebral. Por ejemplo, si después de una caída la niña o el niño manifiesta dolor cervical, dificultad para mover el cuello, debilidad o pérdida de sensibilidad, se debe mantener la cabeza inmóvil y solicitar ayuda especializada, sin intentar cambiar su posición.

El reconocimiento de estos traumatismos permite identificar oportunamente los signos de alarma y aplicar medidas iniciales que reduzcan el riesgo de agravar la lesión. Sin embargo, cuando sea indispensable desplazar a la niña o al niño, se deben emplear técnicas seguras que protejan las zonas afectadas y mantengan la estabilidad corporal durante la movilización y el traslado.

4.4. Movilización y traslado del lesionado

La movilización y el traslado comprenden las acciones utilizadas para desplazar de forma segura a una persona lesionada. En la primera infancia, estas intervenciones requieren de especial cuidado, debido a que un movimiento inadecuado puede agravar

la lesión, afectar otras zonas del cuerpo o generar complicaciones durante la atención inicial.

Antes de movilizar a la niña o al niño, se debe valorar la seguridad del entorno, el tipo de lesión y la necesidad real del desplazamiento. Cuando el lugar no representa un peligro, se recomienda mantener a la persona en una posición estable, evitar movimientos innecesarios y esperar la llegada del personal especializado. Según las condiciones identificadas, pueden presentarse las siguientes situaciones:

- **Movilización de emergencia:** se realiza cuando permanecer en el lugar representa un riesgo mayor que mover a la niña o al niño. Por ejemplo, si ocurre un incendio o una fuga de gas en la vivienda, se debe trasladar a un sitio seguro, protegiendo cabeza, cuello y cuerpo durante el desplazamiento.
- **Movilización no urgente:** se efectúa cuando el entorno es seguro y no existe amenaza inmediata. Por ejemplo, si una niña cae mientras juega en la sala y presenta dolor en una pierna, se debe evitar moverla, inmovilizar la zona, acompañarla y esperar la llegada del personal especializado antes de trasladarla.

La identificación adecuada de cada situación permite evitar desplazamientos innecesarios y seleccionar una actuación acorde con el riesgo presente. En los hogares colombianos, mantener despejadas las rutas de salida, conservar la calma y solicitar apoyo especializado contribuye a proteger a la niña o al niño durante una emergencia.

Para efectuar cualquier desplazamiento indispensable, se deben aplicar criterios que reduzcan el riesgo de movimientos bruscos y protejan las zonas lesionadas. Estos criterios constituyen la base de los principios de la movilización segura.

4.5. Principios de la movilización segura

La movilización segura se fundamenta en principios orientados a proteger a la niña o al niño lesionado durante un desplazamiento indispensable. Su aplicación permite reducir el riesgo de agravar las lesiones, especialmente cuando existe una posible afectación en la cabeza, el cuello, la columna vertebral o las extremidades.

Antes de iniciar cualquier movimiento, se deben valorar las condiciones del entorno, el estado general de la persona lesionada y la necesidad real de trasladarla. Asimismo, es fundamental actuar con calma, solicitar apoyo cuando sea necesario y mantener una comunicación clara entre quienes participan. Para orientar esta actuación, se consideran los siguientes principios:

- **Evaluar la situación:** consiste en valorar el estado de la niña o del niño, identificar la lesión y comprobar los riesgos del entorno antes de intervenir. Por ejemplo, si cae cerca de una escalera, primero se debe asegurar el lugar, observar su respuesta y determinar si resulta indispensable moverlo de inmediato.
- **Asegurar la alineación corporal:** implica mantener la cabeza, el cuello y la columna en una posición estable durante el desplazamiento. Por ejemplo, si una niña cae de una cama y manifiesta dolor cervical, se deben evitar

giros, flexiones o cambios de postura que puedan aumentar el daño mientras llega la ayuda especializada.

- **Inmovilizar la zona lesionada:** consiste en limitar el movimiento de la parte afectada antes de realizar un desplazamiento indispensable. Por ejemplo, si un niño se golpea el brazo al caer en el patio, puede sostenerse la extremidad con una prenda doblada, sin intentar enderezarla ni ejercer presión sobre la lesión.
- **Realizar movimientos controlados:** requiere desplazar a la persona lesionada de manera lenta, coordinada y sin movimientos bruscos. Por ejemplo, ante una fuga de gas en la vivienda, dos adultos pueden trasladar a la niña hacia un lugar seguro, manteniendo alineados la cabeza, el cuello y el tronco durante todo el recorrido.
- **Reevaluar el estado general:** implica observar permanentemente la conciencia, la respiración, la coloración de la piel y otras manifestaciones durante el traslado. Por ejemplo, si el niño se torna somnoliento, respira con dificultad o presenta vómito, se debe detener el desplazamiento, solicitar ayuda especializada y vigilar su estado hasta recibir orientación.

La aplicación conjunta de estos principios permite realizar desplazamientos más seguros y responder de acuerdo con las condiciones de la emergencia. En la primera infancia, la vigilancia permanente resulta esencial, debido a que el estado de la niña o del niño puede cambiar rápidamente durante la atención y requerir apoyo especializado.

La necesidad y la urgencia del desplazamiento determinan la forma más adecuada de movilizar a la persona lesionada. Por ello, es importante diferenciar los

tipos de movilización y reconocer en qué situaciones puede aplicarse cada uno sin aumentar el riesgo de lesión.

4.6. Tipos de movilización

La movilización debe responder a una necesidad concreta de protección o atención. Para tomar una decisión adecuada, se deben diferenciar las situaciones que exigen retirar inmediatamente a la niña o al niño de aquellas que permiten preparar el desplazamiento con mayor precaución y disponer de los apoyos necesarios.

La decisión también depende de la evolución del estado de la persona lesionada, las condiciones del recorrido y la posibilidad de acceder oportunamente a los servicios de salud. El análisis conjunto de estos factores permite anticipar dificultades, organizar los recursos disponibles y evitar que el desplazamiento ocasione nuevos riesgos.

Cada tipo de movilización presenta características particulares relacionadas con la urgencia y los recursos disponibles. Esta clasificación facilita la identificación de la alternativa más apropiada para cada situación:

- A. Movilización de emergencia:** se emplea cuando existe una amenaza inmediata que impide permanecer en el lugar. Por ejemplo, si durante una inundación el agua comienza a ingresar rápidamente a la vivienda, la niña o el niño debe ser llevado a una zona segura. El desplazamiento se realiza solamente hasta eliminar la exposición al peligro y facilitar la atención requerida.
- B. Movilización no urgente:** corresponde al desplazamiento que puede planificarse porque las condiciones del lugar permanecen controladas. Por

ejemplo, si un niño presenta una lesión después de caer en el jardín y requiere valoración médica, se conserva su posición mientras se organiza el traslado con orientación profesional, sin apresurarlo ni obligarlo a caminar para llegar al medio de transporte.

C. Movilización asistida: se utiliza cuando la persona lesionada necesita ayuda para desplazarse debido a su estado físico o a las características del recorrido. Por ejemplo, si una niña se lesiona en una zona rural de difícil acceso, las personas capacitadas pueden emplear un recurso de traslado apropiado y distribuir responsabilidades para acompañarla hasta el punto donde será recibida por el personal especializado.

La clasificación presentada permite comprender que no todos los desplazamientos responden a las mismas circunstancias. Una vez identificado el tipo de movilización requerido, se seleccionan las técnicas de traslado acordes con el estado de la persona lesionada, el lugar y los recursos disponibles.

4.7. Técnicas de traslado

Las técnicas de traslado corresponden a las formas de desplazar a una niña o un niño lesionado cuando esta acción resulta necesaria. La elección debe considerar su edad, tamaño, capacidad para colaborar, zona afectada y estado general. También se debe verificar que la técnica seleccionada pueda aplicarse con seguridad y con los apoyos disponibles.

Antes de realizar el traslado, es necesario organizar la intervención para evitar improvisaciones. Para ello, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

- a) Comprobar el estado general de la niña o del niño.
- b) Identificar las zonas lesionadas que requieren protección.
- c) Verificar que el recorrido esté libre de obstáculos.
- d) Definir las funciones de las personas que prestarán ayuda.
- e) Preparar los elementos necesarios para el desplazamiento.

Una vez verificadas estas condiciones, se puede seleccionar la técnica que responda a las características de la situación:

- **Cargue en brazos:** se emplea con lactantes o niñas y niños pequeños que, por su edad o condición, no pueden desplazarse. La persona que brinda ayuda debe sostener la cabeza, el cuello, la espalda y las piernas. Esta técnica no debe aplicarse cuando existan señales de lesión en la columna vertebral, excepto ante un peligro inmediato.
- **Arrastre de emergencia:** permite retirar a la persona lesionada de un lugar que representa una amenaza inmediata, como un incendio, una fuga de gas o el riesgo de derrumbe. El desplazamiento debe limitarse hasta alcanzar una zona segura, procurando mantener el cuerpo alineado y evitar que la cabeza o las extremidades golpeen contra el suelo u otros objetos.
- **Traslado con apoyo:** se utiliza cuando la niña o el niño permanece consciente, puede seguir indicaciones y conserva parcialmente la capacidad para caminar. La persona auxiliadora se ubica al lado afectado para proporcionar estabilidad. Esta técnica puede aplicarse ante una molestia leve, siempre que no existan mareo, dolor intenso o sospecha de lesión grave.

- **Traslado asistido por dos personas:** se aplica cuando el peso, el estado físico o las condiciones del recorrido requieren ayuda adicional. Las personas encargadas deben acordar quién dirigirá la maniobra, distribuir los puntos de apoyo y realizar el desplazamiento de manera coordinada. No se debe levantar a la niña o al niño sujetándolo únicamente por los brazos o las piernas.

La técnica seleccionada debe modificarse o suspenderse si durante el recorrido aparecen dificultad para respirar, pérdida de respuesta, dolor intenso, vómito o cambios en la coloración de la piel. En estas situaciones, se debe ubicar a la persona lesionada en un lugar seguro, solicitar atención especializada y mantener la vigilancia de su estado general.

El traslado no consiste únicamente en cambiar de lugar a la persona lesionada. Su propósito es protegerla durante un desplazamiento indispensable, sin aumentar el dolor ni agravar las lesiones existentes.

El conocimiento de estas técnicas fortalece la capacidad de respuesta ante lesiones y traumatismos en la primera infancia. Asimismo, permite actuar con mayor seguridad frente a otras situaciones específicas que requieren observación, reconocimiento de signos de alarma y atención inicial oportuna.

5. Situaciones específicas y enfermedades prevalentes

Durante la primera infancia pueden presentarse accidentes y alteraciones de salud que evolucionan rápidamente y requieren una respuesta oportuna. Entre estas situaciones se encuentran la presencia de cuerpos extraños, las picaduras, las mordeduras, las convulsiones y las intoxicaciones. También son frecuentes algunas enfermedades respiratorias, gastrointestinales, dermatológicas, nutricionales e inmunoprevenibles.

Aunque estas situaciones tienen causas y manifestaciones diferentes, su atención inicial parte de una actuación común: observar el estado general de la niña o del niño, reconocer los cambios que indican gravedad y aplicar únicamente las medidas que correspondan al nivel de formación del primer respondiente. Esta valoración permite decidir si se requiere vigilancia, consulta médica prioritaria o activación inmediata del sistema de emergencias.

En los hogares, jardines infantiles y demás espacios de cuidado pueden ocurrir situaciones cotidianas como las siguientes:

- Una niña introduce una semilla o un objeto pequeño en la nariz mientras juega.
- Un niño presenta inflamación y dificultad respiratoria después de la picadura de un insecto.
- Una niña desarrolla una convulsión asociada con fiebre alta.
- Un niño ingiere accidentalmente un medicamento o producto de limpieza almacenado a su alcance.

Estas situaciones muestran la importancia de conservar la calma, proteger a la niña o al niño y evitar procedimientos improvisados. La intervención debe centrarse en reconocer los signos presentes, prevenir nuevos riesgos y solicitar ayuda profesional cuando la condición supere la capacidad de respuesta disponible.

La atención oportuna comienza con una observación cuidadosa. Reconocer qué ocurrió, cómo responde la niña o el niño y cuáles cambios requieren ayuda inmediata permite actuar con mayor seguridad.

El reconocimiento inicial de estas condiciones facilita la selección de medidas acordes con cada evento. Por ello, el siguiente apartado presenta las situaciones específicas que requieren primeros auxilios y las acciones básicas que pueden aplicarse mientras se obtiene atención especializada.

5.1. Atención de situaciones específicas

La atención de situaciones específicas comprende las medidas iniciales aplicadas ante eventos que pueden afectar repentinamente la salud de una niña o un niño. Su propósito es proteger la vida, disminuir la exposición al peligro y evitar que la condición se agrave mientras se solicita orientación o atención profesional.

Para actuar de manera segura, el primer respondiente debe identificar el evento, reconocer sus manifestaciones y valorar los posibles riesgos. No se deben realizar maniobras invasivas, administrar sustancias ni aplicar tratamientos que correspondan al personal de salud. La intervención debe limitarse a las acciones básicas para las cuales se cuenta con preparación.

Las principales situaciones que requieren atención inicial son:

- **Cuerpos extraños:** se presentan cuando un objeto ingresa en los ojos, la nariz, los oídos o la vía aérea. Pueden causar dolor, irritación, secreción, tos o dificultad respiratoria. No se debe manipular ni introducir otro elemento para extraerlo. Si el objeto no es visible, existe sangrado o se compromete la respiración, se requiere atención inmediata.
- **Picaduras y mordeduras:** pueden ocasionar dolor, enrojecimiento, inflamación, prurito, infección o reacción alérgica. Se debe limpiar la zona, aplicar frío local protegido y observar la evolución. Ante hinchazón generalizada, dificultad respiratoria, alteración de la conciencia o mordedura de un animal desconocido, se debe solicitar atención médica inmediata.
- **Convulsiones:** se manifiestan mediante movimientos involuntarios, rigidez, pérdida de respuesta o alteración de la conciencia. Se debe proteger a la niña o al niño de golpes, retirar los objetos cercanos y colocarlo de lado cuando sea posible. No se deben sujetar sus movimientos ni introducir objetos en la boca. Es importante controlar la duración del episodio.
- **Intoxicaciones:** ocurren por contacto, inhalación o ingestión de medicamentos, sustancias químicas, productos de limpieza u otros elementos tóxicos. Se debe identificar el producto, conservar su envase y solicitar orientación especializada. No se debe inducir el vómito, ofrecer alimentos ni administrar remedios caseros, porque estas acciones pueden aumentar el daño.

El reconocimiento de estas situaciones permite aplicar medidas diferentes de acuerdo con el tipo de evento. En todos los casos, la observación continua resulta indispensable para detectar cambios en la respiración, la conciencia, la coloración de la piel o el comportamiento.

Ante una situación específica, intervenir de forma segura significa realizar solamente las acciones necesarias, evitar maniobras improvisadas y solicitar ayuda cuando aparezcan signos de gravedad.

Una vez atendido el evento inmediato, es necesario considerar otras alteraciones de salud que pueden manifestarse de manera progresiva. Entre ellas se encuentran las enfermedades prevalentes, cuyo reconocimiento favorece la consulta temprana y la prevención de complicaciones.

A. Enfermedades prevalentes en la primera infancia

Las enfermedades prevalentes son condiciones de salud que se presentan con mayor frecuencia durante los primeros años de vida. Su aparición puede relacionarse con la inmadurez del sistema inmunológico, las condiciones del entorno, el acceso al agua segura, la alimentación, la higiene, la vacunación y la exposición a agentes infecciosos.

El primer respondiente no tiene la función de diagnosticar ni tratar estas enfermedades. Su responsabilidad consiste en reconocer cambios que puedan indicar deterioro, brindar una atención inicial segura y orientar a la familia o al cuidador sobre la necesidad de acudir a los servicios de salud.

En el contexto colombiano, algunas condiciones ambientales, sociales y sanitarias pueden aumentar la aparición de enfermedades durante la primera infancia. Entre ellas se encuentran:

- **Temporadas de lluvia:** durante las lluvias aumenta la exposición a humedad, aguas estancadas y vectores, lo cual favorece enfermedades respiratorias, gastrointestinales e infecciosas.
- **Cambios de temperatura:** los cambios de temperatura pueden debilitar las defensas y favorecer tos, congestión, fiebre o dificultad respiratoria en niñas y niños.
- **Espacios comunitarios:** la permanencia en jardines, hogares comunitarios u otros espacios compartidos facilita el contacto con personas enfermas y agentes infecciosos circulantes.
- **Agua o alimentos contaminados:** el consumo de agua o alimentos contaminados puede causar diarrea, vómito, dolor abdominal y deshidratación, especialmente durante la primera infancia.
- **Vacunación incompleta:** los esquemas de vacunación incompletos reducen la protección frente a enfermedades prevenibles y aumentan el riesgo de complicaciones graves posteriores.
- **Dificultades de acceso:** las dificultades para acceder a controles médicos retrasan la detección de alteraciones y el inicio oportuno del tratamiento profesional requerido.

El reconocimiento de estas condiciones permite fortalecer las acciones preventivas en el hogar y orientar oportunamente la consulta ante cambios en la salud.

Antes de describir las principales patologías, es importante reconocer que cada una presenta manifestaciones particulares y puede afectar de manera diferente el bienestar de las niñas y los niños. Su clasificación facilita la comprensión de los síntomas más frecuentes y orienta la identificación oportuna de los cambios que requieren valoración por parte del personal de salud.

5.2. Principales enfermedades prevalentes

Durante la primera infancia, algunas enfermedades pueden iniciar con manifestaciones leves y evolucionar rápidamente. Por ello, es fundamental observar de manera continua el estado general de la niña o del niño e identificar cambios que indiquen la necesidad de una valoración profesional. Para orientar esta observación, se deben considerar los siguientes aspectos:

- **Respiración:** identificar dificultad, sonidos inusuales o cambios en el ritmo respiratorio.
- **Hidratación:** observar sequedad en la boca, ausencia de lágrimas o disminución de la orina.
- **Temperatura corporal:** reconocer fiebre persistente, temperatura baja o variaciones repentinas.
- **Piel:** verificar cambios de coloración, erupciones, inflamación o aparición de lesiones.
- **Alimentación:** prestar atención al rechazo de alimentos o líquidos y a la pérdida del apetito.

- **Comportamiento:** reconocer somnolencia excesiva, irritabilidad, debilidad o menor respuesta a los estímulos.

La observación conjunta de estos aspectos permite detectar oportunamente un posible deterioro de la salud y solicitar la atención necesaria, sin establecer diagnósticos ni administrar tratamientos por iniciativa propia.

Antes de explorar las principales enfermedades prevalentes, es importante reconocer que cada una puede afectar de manera diferente la salud de las niñas y los niños. El siguiente recurso interactivo permite conocer sus características, manifestaciones y principales medidas de prevención, así como identificar los cambios que requieren valoración oportuna por parte del personal de salud.

a) Enfermedades respiratorias

Son una de las principales causas de consulta y hospitalización en la primera infancia; incluyen resfriado común, bronquiolitis y neumonía, causa importante de mortalidad infantil mundial.

b) Enfermedades gastrointestinales

Las enfermedades diarreicas agudas son frecuentes en la infancia y se asocian a infecciones virales, bacterianas o parasitarias; su riesgo principal es la deshidratación por pérdida de líquidos y electrolitos.

c) Alteraciones nutricionales

La desnutrición y la anemia constituyen un problema de salud pública en la primera infancia; la desnutrición afecta el crecimiento y el desarrollo cognitivo, y la anemia afecta el aprendizaje.

d) Enfermedades parasitarias

Las parasitosis intestinales son frecuentes donde existen deficiencias en saneamiento básico e higiene; generan síntomas como dolor abdominal, diarrea, pérdida de peso y alteraciones nutricionales en la infancia.

e) Enfermedades dermatológicas

Las afecciones de la piel en la primera infancia incluyen dermatitis e infecciones bacterianas o micóticas, asociadas a condiciones de higiene, humedad o irritación, frecuentes en jardines infantiles.

f) Enfermedades inmunoprevenibles

Enfermedades como sarampión, tosferina y varicela siguen representando un riesgo en poblaciones infantiles con esquemas de inmunización incompletos o atrasados en Colombia.

El reconocimiento de las enfermedades prevalentes en la primera infancia favorece la prevención y la detección temprana de cambios en el estado de salud. La observación de signos y síntomas, junto con el acceso oportuno a los servicios de salud, permite orientar una atención adecuada y reducir el riesgo de complicaciones.

Además de identificar las manifestaciones de estas enfermedades, es fundamental reconocer aquellas señales que pueden indicar un deterioro de la salud. A continuación, se abordan los principales signos de alarma y las acciones iniciales que deben realizarse ante su aparición.

5.3. Signos de alarma

Durante la primera infancia, algunas alteraciones de salud pueden evolucionar rápidamente y comprometer el bienestar de la niña o del niño. Los signos de alarma son manifestaciones que permiten reconocer un posible deterioro y orientan la necesidad de solicitar atención profesional prioritaria o activar inmediatamente el sistema de emergencias.

La observación debe centrarse en los cambios relacionados con la respiración, el estado de conciencia, la hidratación, la temperatura corporal, la circulación, la alimentación y el comportamiento. Para reconocer una situación que requiere atención, no es necesario establecer un diagnóstico; se debe identificar cualquier manifestación inusual y valorar su evolución.

El reconocimiento temprano de los signos de alarma permite solicitar atención oportuna y reducir el riesgo de complicaciones. Estas manifestaciones no deben minimizarse ni tratarse mediante medicamentos o procedimientos sin orientación profesional.

Los principales signos de alarma y las conductas iniciales que deben aplicarse son:

- **Dificultad respiratoria:** la respiración rápida, el hundimiento entre las costillas, el aleteo nasal, los sonidos inusuales o la coloración azulada pueden indicar falta de oxígeno. Se debe mantener despejada la vía aérea, ubicar a la niña o al niño en una posición que facilite la respiración y evitar ofrecer alimentos o bebidas. Es necesario activar inmediatamente el

sistema de emergencias y observar cualquier cambio mientras llega el personal especializado.

- **Alteraciones neurológicas:** las convulsiones, la somnolencia excesiva, la irritabilidad persistente o la falta de respuesta pueden relacionarse con fiebre, infección, traumatismo u otra alteración grave. Se debe proteger a la niña o al niño de posibles golpes, retirar los objetos cercanos y colocarlo de lado cuando sea posible. No se deben sujetar sus movimientos ni introducir elementos en la boca. También es necesario controlar la duración del episodio y solicitar atención inmediata.
- **Deshidratación:** el vómito persistente, la diarrea frecuente, el rechazo de líquidos, la boca seca, los ojos hundidos o la ausencia de lágrimas pueden indicar pérdida importante de líquidos. Si la niña o el niño está consciente y puede beber, se deben ofrecer pequeñas cantidades de solución de rehidratación oral. No se deben administrar medicamentos ni preparaciones caseras sin orientación profesional. Si las manifestaciones persisten o empeoran, se requiere valoración médica inmediata.
- **Alteraciones de la temperatura:** la fiebre persistente, la temperatura corporal baja o el decaimiento general pueden indicar una infección u otra condición que requiere valoración. Se debe comprobar la temperatura, retirar el exceso de abrigo y mantener un ambiente ventilado. No se recomienda aplicar alcohol, hielo ni baños con agua fría. Si aparecen convulsiones, somnolencia, dificultad respiratoria o deterioro progresivo, se debe solicitar atención profesional de inmediato.
- **Alteraciones circulatorias:** la palidez marcada, la piel fría, el pulso débil o la recuperación lenta del color de la piel pueden indicar una alteración de la

circulación. La niña o el niño debe permanecer en reposo, abrigado y bajo vigilancia continua. No se deben ofrecer alimentos ni bebidas. Se debe activar el sistema de emergencias y observar permanentemente la respiración, el estado de conciencia y la coloración mientras llega el personal especializado.

- **Alteraciones nutricionales:** la pérdida de peso, la falta de crecimiento, la debilidad o el rechazo persistente de los alimentos pueden relacionarse con una alteración nutricional u otra enfermedad. Se debe observar cuánto tiempo lleva la dificultad, registrar los cambios en el apetito e informar a la familia o al cuidador. No se debe forzar la alimentación. La valoración médica y nutricional permitirá identificar la causa y establecer el seguimiento correspondiente.
- **Cambios de comportamiento:** el llanto inconsolable, la debilidad extrema, la irritabilidad o una conducta diferente de la habitual pueden indicar dolor o enfermedad. Se debe identificar cuándo comenzaron los cambios y observar si están acompañados de fiebre, golpes, dificultad respiratoria u otras manifestaciones. No se deben atribuir únicamente al cansancio. Si persisten, empeoran o se acompañan de menor respuesta a los estímulos, se requiere atención médica inmediata.

La valoración conjunta de estas manifestaciones permite determinar la urgencia de la atención. Al comunicarse con el personal de salud, se debe informar claramente qué ocurrió, cuándo comenzaron los signos, cómo han evolucionado y qué medidas iniciales se aplicaron.

Ante cualquier signo de alarma, se debe mantener la calma, vigilar permanentemente el estado de la niña o del niño y solicitar ayuda. La actuación oportuna debe proteger su salud sin reemplazar la valoración del personal especializado.

El reconocimiento de los signos de alarma debe complementarse con una comunicación clara y oportuna. Informar adecuadamente la situación, acompañar emocionalmente a la niña o al niño y seguir las indicaciones del sistema de emergencias contribuye a brindar una atención inicial segura.

6. Comunicación, emergencias y cadena de custodia

La atención inicial de una emergencia en la primera infancia también requiere acompañar emocionalmente a la niña o al niño, comunicar la situación con claridad y coordinar oportunamente la intervención de los servicios especializados. Estas acciones favorecen una respuesta organizada y permiten mantener informados a los familiares, cuidadores y profesionales que participan en la atención.

Cuando el evento puede tener implicaciones legales, también es necesario proteger la escena, evitar la manipulación de objetos y registrar únicamente la información observada. Estas actuaciones deben realizarse sin retrasar los primeros auxilios, debido a que la protección de la vida y la salud de la persona afectada constituye la prioridad.

Para comprender la relación entre estas acciones, se deben considerar los siguientes aspectos:

- **Acompañamiento emocional:** ayuda a disminuir el miedo, la angustia y la confusión que puede experimentar la niña o el niño.
- **Comunicación durante la atención:** permite explicar las acciones mediante palabras sencillas, frases breves y un tono tranquilo.
- **Activación del sistema de emergencias:** comunicarse con la línea de emergencias 123 para reportar con claridad la condición de la niña o del niño y su ubicación exacta.
- **Protección de la información:** evita divulgar datos personales, imágenes o detalles que puedan afectar la intimidad de la persona involucrada.

- **Preservación de la escena:** contribuye a evitar la alteración de objetos, rastros o elementos relacionados con una posible investigación.

El desarrollo articulado de estos aspectos fortalece la actuación del primer respondiente. No obstante, cada acción debe aplicarse de acuerdo con las características del evento, el estado de la niña o del niño y las indicaciones de las autoridades competentes.

La comunicación clara, el acompañamiento respetuoso y la coordinación oportuna complementan la atención física y contribuyen a proteger integralmente a la niña o al niño.

A continuación, se aborda el acompañamiento emocional durante una emergencia y la comunicación con la persona afectada, sus familiares y cuidadores.

6.1. Primeros auxilios psicológicos y comunicación

Una emergencia puede generar miedo, llanto, confusión, silencio o dificultad para seguir indicaciones. Los primeros auxilios psicológicos comprenden acciones inmediatas de apoyo que buscan brindar seguridad, disminuir la angustia y favorecer una respuesta emocional más estable mientras se desarrolla la atención.

La reacción puede variar según la edad, el desarrollo, las experiencias previas y las características del evento. Por esta razón, se debe observar el comportamiento, respetar las manifestaciones emocionales y adaptar la comunicación a la capacidad de comprensión de cada niña o niño.

El acompañamiento inicial debe orientarse mediante las siguientes acciones:

- **Acercarse de manera tranquila:** ubicarse a una distancia apropiada, presentarse y evitar movimientos que puedan generar mayor temor.
- **Escuchar con atención:** permitir que la niña o el niño exprese lo ocurrido, sin presionarlo, interrumpirlo ni formular preguntas repetitivas.
- **Reconocer sus emociones:** aceptar el miedo, la tristeza o la confusión sin minimizar estas manifestaciones ni emitir juicios.
- **Explicar las acciones:** informar de manera progresiva qué se va a realizar y emplear palabras comprensibles para su edad.
- **Brindar seguridad:** permanecer cerca, mantener un tono sereno y comunicar que se está gestionando la ayuda necesaria.
- **Favorecer el contacto protector:** facilitar el acompañamiento de una persona cuidadora conocida, siempre que su presencia sea segura y beneficiosa.

Estas acciones permiten establecer un entorno de confianza durante la atención. No se deben hacer promesas que no puedan cumplirse, exigir que la persona relate el evento ni utilizar expresiones que aumenten su preocupación.

A. Comunicación con la niña o el niño

La comunicación debe adaptarse a la edad, el estado emocional y la capacidad de respuesta.

Para facilitar la comprensión, se recomienda:

- a) Utilizar frases breves y palabras conocidas.
- b) Dar una indicación a la vez.

- c) Mantener un tono de voz calmado.
- d) Comprobar si la información fue comprendida.
- e) Evitar explicaciones alarmantes o innecesarias.
- f) Respetar los silencios y el tiempo necesario para responder.

La comunicación no verbal también transmite seguridad. La postura corporal, la expresión facial, el contacto visual respetuoso y la distancia adecuada deben ser coherentes con el mensaje expresado.

B. Comunicación con familiares o cuidadores

Los familiares o cuidadores deben recibir información objetiva sobre el estado observado, las acciones realizadas y la ayuda solicitada. La comunicación debe evitar diagnósticos, afirmaciones sin confirmar o señalamientos sobre posibles responsabilidades. Para mantener una comunicación clara y respetuosa, es importante:

- a) Informar qué ocurrió y en qué momento.
- b) Describir las manifestaciones observadas.
- c) Explicar las medidas de atención aplicadas.
- d) Comunicar si se solicitó ayuda especializada.
- e) Indicar las recomendaciones recibidas.
- f) Evitar divulgar información frente a personas ajenas al evento.

Una comunicación respetuosa ayuda a disminuir la incertidumbre y facilita la participación de la familia o del cuidador en la continuidad de la atención.

Para fortalecer la comprensión de estos contenidos, se presenta un recurso de audio sobre el acompañamiento emocional del niño o la niña durante una emergencia. En este se explica en qué consisten los primeros auxilios psicológicos, la importancia de la calma y la palabra como herramienta del primer respondiente, y la forma de acompañar al menor sin generar más angustia mientras llega la ayuda especializada.

Transcripción del pódcast. Voz que tranquiliza: acompañar al niño en la emergencia

Mujer: un niño que acaba de sufrir un accidente difícilmente entiende qué está pasando. Lo primero que siente es miedo.

Hombre: y mientras los adultos corremos a controlar la emergencia, a veces se nos olvida que el niño también necesita sentirse seguro.

Mujer: una voz tranquila, una explicación sencilla o una mano que transmita seguridad pueden cambiar por completo la manera como un niño vive ese momento.

Hombre: claro, porque si quien atiende la emergencia llega alterado, gritando o actuando con desesperación, lo único que consigue es aumentar el miedo del menor. Lo primero es conservar la calma para transmitir seguridad.

Mujer: esa tranquilidad se transmite escuchando, mirando al niño a los ojos y hablándole con un tono de voz sereno, especialmente en momentos como ese, cuando muchas veces ni siquiera encuentra las palabras para decir lo que siente.

Hombre: como cuando una niña se quema con agua caliente en la cocina. Mientras se enfría la zona afectada con agua y se protege la lesión con un material

limpio, también hay que explicarle, con palabras sencillas, lo que está ocurriendo y lo que va a pasar mientras llega la ayuda.

Mujer: nada de gritos, movimientos bruscos o caras de preocupación. Tratar al niño con empatía y respetar sus reacciones puede disminuir el impacto emocional que deja la emergencia.

Hombre: y eso también les da tranquilidad a los adultos. Cuando un niño siente calma, resulta mucho más fácil atenderlo sin aumentar el estrés de quienes están a su alrededor.

Mujer: los padres o cuidadores también necesitan recibir una explicación clara sobre lo que pasó, las acciones que se realizaron y la necesidad de trasladar al menor a un servicio de salud cuando la situación lo requiera.

Hombre: porque cuando los adultos entienden lo que está pasando, también recuperan parte de la calma. Y esa tranquilidad termina reflejándose en el niño.

Mujer: es que atender una emergencia también es acompañar al niño mientras vuelve a sentirse seguro.

Hombre: una voz calmada, una explicación sencilla y una presencia que transmita confianza hacen parte de los primeros auxilios.

Mujer: porque una buena atención ayuda a que el niño atraviese ese momento con la mayor tranquilidad posible mientras recibe la atención que necesita.

El acompañamiento emocional oportuno contribuye a reducir el impacto de la emergencia en la niña o el niño y facilita la atención física necesaria. Sin embargo, esta

contención no reemplaza la atención especializada; por ello, a continuación, se presenta la articulación con el sistema de emergencias y su importancia para garantizar la continuidad del cuidado.

6.2. Articulación con el sistema de emergencias

La articulación con el sistema de emergencias permite solicitar ayuda especializada y garantizar la continuidad de la atención cuando una situación supera la capacidad de actuación del primer respondiente. Este proceso requiere identificar la necesidad de apoyo, comunicarse oportunamente con la línea de emergencias y proporcionar información clara sobre el estado de la niña o del niño.

En Colombia, la activación debe realizarse mediante la línea de emergencias 123. Durante la llamada, es importante mantener la calma, responder las preguntas del operador y seguir las indicaciones recibidas, sin interrumpir la comunicación hasta que se autorice finalizarla.

A. Activación del sistema de emergencias

Para realizar una activación organizada y facilitar la respuesta del personal especializado, se deben considerar las siguientes acciones:

- **Reconocer la emergencia:** identificar los signos de alarma o las condiciones que requieren atención especializada.
- **Comunicarse con la línea 123:** reportar con claridad la condición de la niña o del niño y su ubicación exacta.
- **Informar la ubicación:** indicar el municipio, el barrio, la dirección, un punto de referencia y las condiciones de acceso al lugar.

- **Describir lo ocurrido:** explicar brevemente el evento, el número de personas afectadas y las manifestaciones observadas.
- **Comunicar las acciones realizadas:** informar los primeros auxilios brindados y los cambios identificados durante la atención.
- **Seguir las indicaciones:** escuchar al operador y aplicar las orientaciones recibidas de acuerdo con las condiciones de seguridad.
- **Facilitar el acceso:** despejar el recorrido y, cuando sea posible, asignar a una persona para orientar al equipo de emergencias.
- **Entregar la información:** comunicar al personal especializado la evolución de la niña o del niño y las acciones realizadas.

El cumplimiento ordenado de estas acciones facilita la comprensión del evento y permite que los organismos de respuesta determinen los recursos necesarios. La información suministrada debe ser concreta, verificable y limitada a los hechos observados.

B. Información que debe comunicarse

Durante la llamada, se deben proporcionar los datos esenciales para orientar la respuesta:

- **Situación presentada:** qué ocurrió y cómo sucedió, si esta información se conoce.
- **Ubicación exacta:** dirección, municipio, barrio, punto de referencia y condiciones de acceso.
- **Persona afectada:** edad aproximada y estado actual de la niña o del niño.

- **Manifestaciones observadas:** cambios en la respiración, el estado de conciencia, la circulación, la movilidad o el comportamiento.
- **Primeros auxilios realizados:** acciones aplicadas antes y durante la llamada.
- **Riesgos presentes:** fuego, humo, sustancias peligrosas, tránsito, violencia u otras condiciones que puedan afectar la atención.
- **Datos de contacto:** nombre y número telefónico de la persona que realiza el reporte.

Estos datos permiten que el operador comprenda la situación y proporcione instrucciones apropiadas. Si alguna información se desconoce, debe indicarse con claridad, sin realizar suposiciones ni emitir diagnósticos.

Durante la llamada a la línea de emergencias 123, se debe informar qué ocurrió, dónde sucedió, cómo se encuentra la niña o el niño y cuáles acciones se han realizado.

C. Actuación mientras llega la ayuda

La atención no termina después de realizar la llamada. Mientras llega el personal especializado, el primer respondiente debe continuar con las siguientes acciones:

- Mantener la vigilancia sobre la respiración, el estado de conciencia y la condición general.
- Aplicar las indicaciones proporcionadas por el operador de emergencias.
- Evitar movilizar a la niña o al niño, salvo que permanezca expuesto a un peligro inmediato.
- Mantener despejado y seguro el lugar de atención.
- Informar cualquier cambio significativo mediante la línea de emergencias.

- Preparar la información necesaria para entregarla al personal especializado.

La vigilancia continua permite reconocer cambios que puedan requerir nuevas acciones. En todo momento, se debe conservar la calma, proteger a la niña o al niño y evitar procedimientos que no hayan sido indicados por personal capacitado.

D. Entrega al personal especializado

Cuando llegue el equipo de emergencias, se debe realizar una entrega clara y ordenada de la información.

Para ello, se debe comunicar:

- Qué ocurrió y a qué hora aproximadamente.
- Cuáles manifestaciones se observaron inicialmente.
- Cómo evolucionó el estado de la niña o del niño.
- Qué primeros auxilios se realizaron.
- Qué indicaciones proporcionó el operador de la línea 123.
- Si existen antecedentes relevantes informados por la familia o el cuidador.

La entrega de esta información favorece la continuidad del cuidado y evita la pérdida de datos importantes. Una vez que el personal especializado asuma la atención, se deben seguir sus indicaciones y evitar interferir en los procedimientos.

La articulación con el sistema de emergencias integra la solicitud de ayuda, la comunicación precisa, la vigilancia y la entrega responsable de la información. Cuando el evento también puede tener implicaciones legales, se deben proteger el lugar, los

elementos relacionados y la intimidad de la niña o del niño, aspectos que se abordan en el siguiente numeral.

6.3. Cadena de custodia

Cuando una emergencia se relaciona con un accidente grave, una posible situación de violencia u otro hecho que requiera investigación, se debe proteger el lugar y evitar alteraciones innecesarias. Estas acciones contribuyen a conservar la información y los elementos que posteriormente pueden ser examinados por las autoridades competentes.

La cadena de custodia es un procedimiento técnico que permite identificar, conservar, trasladar y entregar los elementos materiales probatorios y la evidencia física. Su aplicación corresponde a las autoridades y al personal legalmente facultado. Por tanto, el primer respondiente debe brindar la atención inicial, proteger el lugar y comunicar objetivamente lo observado, sin asumir funciones investigativas.

A. Prioridad durante la atención

La protección de la vida y la salud de la niña o del niño siempre es prioritaria. Si para brindar los primeros auxilios es indispensable ingresar al lugar, mover un objeto o modificar alguna condición del entorno, se debe realizar únicamente la acción necesaria e informar posteriormente a la autoridad.

B. Actuaciones del primer respondiente

Para proteger el lugar y apoyar la intervención de las autoridades, se deben aplicar las siguientes acciones:

- a) **Verificar la seguridad:** identificar los riesgos para la niña, el niño y las demás personas presentes.
- b) **Activar el sistema de emergencias:** comunicarse con la línea de emergencias 123 para reportar con claridad la condición de la niña o del niño y su ubicación exacta.
- c) **Restringir el acceso:** evitar, cuando sea seguro, el ingreso de personas ajenas al evento.
- d) **Conservar el lugar:** procurar que los objetos permanezcan en la posición y el estado en que fueron encontrados.
- e) **Evitar manipulaciones:** no mover, limpiar, recoger, lavar, desechar ni trasladar objetos relacionados con el evento.
- f) **Registrar los hechos:** anotar la fecha, la hora aproximada, el lugar, las condiciones observadas, los primeros auxilios brindados y las modificaciones realizadas.
- g) **Proteger la intimidad:** impedir la toma o divulgación de fotografías, videos, audios y datos personales.
- h) **Entregar la información:** comunicar al personal especializado las actuaciones realizadas y los cambios indispensables efectuados durante la atención.

Estas acciones permiten apoyar la protección de la escena sin asumir procedimientos propios de las autoridades. El primer respondiente no debe recolectar, embalar, rotular ni trasladar posibles evidencias, salvo que reciba una instrucción expresa de la autoridad competente.

C. Manejo de la información

El registro debe limitarse a hechos observables, sin incluir acusaciones, interpretaciones ni conclusiones personales. Si la niña o el niño expresa espontáneamente información sobre lo ocurrido, sus palabras deben registrarse con fidelidad, sin completar el relato ni formular preguntas que sugieran respuestas.

La información debe compartirse únicamente con el personal de salud, los familiares o cuidadores responsables y las autoridades facultadas. No se deben divulgar nombres, imágenes ni detalles del evento mediante redes sociales u otros medios. Cuando existan indicios de violencia, maltrato o abuso, la situación debe informarse inmediatamente a las autoridades competentes.

Para ampliar los conocimientos sobre los procedimientos relacionados con la protección de la escena y la cadena de custodia, se recomienda consultar el manual de la Fiscalía General de la Nación, disponible en el siguiente enlace:

<https://safgncacportalwebprod01.blob.core.windows.net/media-portalweb-prd/MANUAL-DEL-SISTEMA-DE-CADENA-DE-CUSTODIA.pdf>

La protección de la escena, el registro objetivo y el manejo reservado de la información contribuyen a preservar los elementos relacionados con el evento y a garantizar los derechos de la niña o del niño. La actuación del primer respondiente debe centrarse en priorizar la vida, evitar alteraciones innecesarias y facilitar la intervención de las entidades responsables.

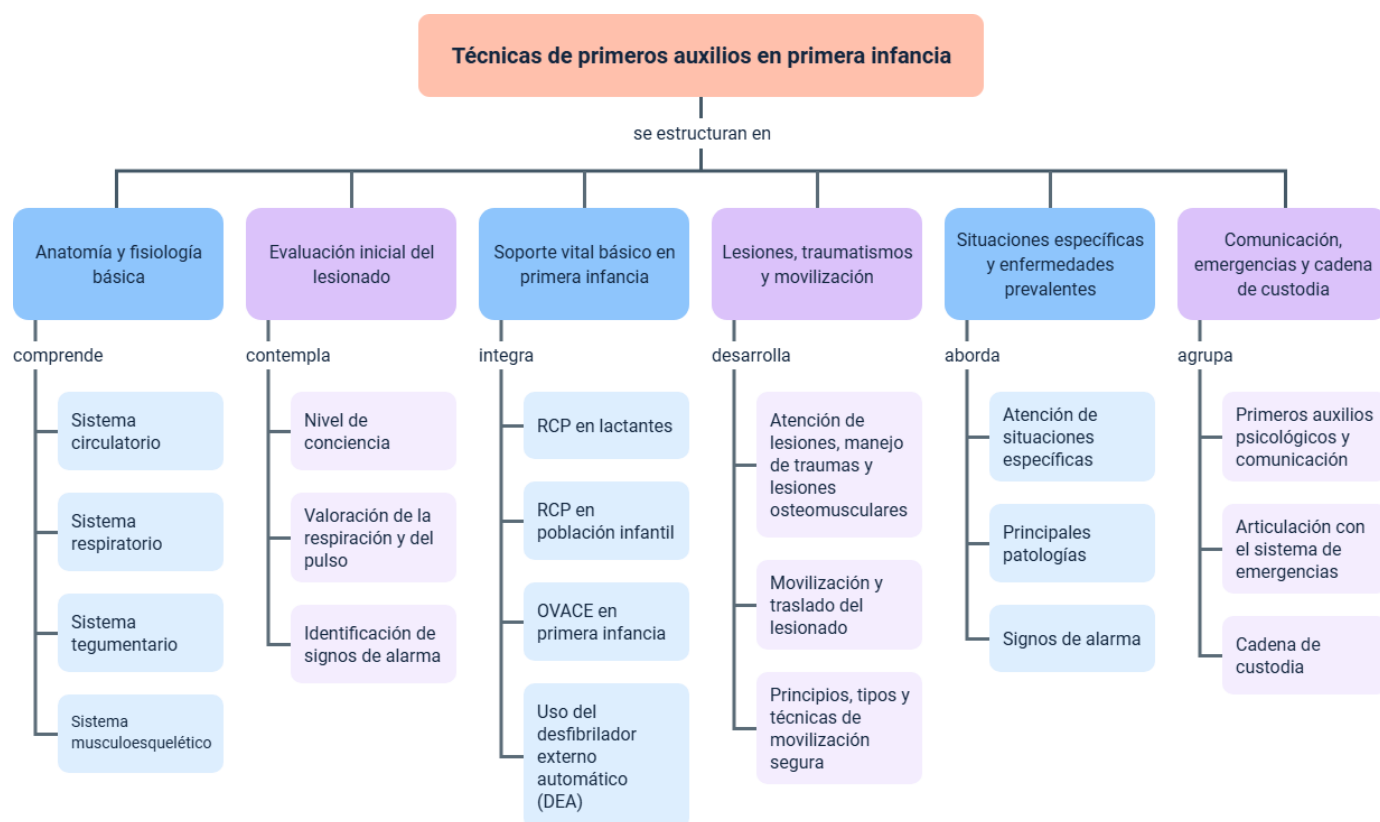
Al finalizar este componente formativo, se reconoce que actuar ante una emergencia en la primera infancia requiere conocimientos, calma, responsabilidad y

sensibilidad. Cada acción oportuna contribuye a proteger la vida, brindar un acompañamiento respetuoso y facilitar la atención especializada de la niña o del niño.

Síntesis

El componente formativo desarrolla los fundamentos y procedimientos esenciales para la atención de emergencias en la primera infancia, integrando conocimientos de anatomía y fisiología básica, evaluación inicial del lesionado y aplicación del soporte vital básico. A partir de estos elementos, se fortalecen las capacidades para reconocer situaciones críticas, interpretar signos de alarma y ejecutar intervenciones oportunas y seguras.

De igual forma, se abordan las principales lesiones y situaciones específicas que pueden presentarse en esta etapa, así como la movilización del lesionado, la comunicación con el menor y la articulación con el sistema de emergencias. Todo ello con el propósito de garantizar una atención integral, segura y oportuna que proteja la vida y la salud de niñas y niños en las diferentes situaciones de emergencia. A continuación, el mapa conceptual organiza de manera visual los ejes temáticos del componente formativo y las relaciones que los articulan.



Glosario

Anatomía: ciencia que estudia la estructura y la organización de las partes del cuerpo humano, base para comprender su funcionamiento en la atención de primeros auxilios.

Bioseguridad: conjunto de medidas y prácticas orientadas a prevenir riesgos biológicos y proteger la salud del primer respondiente y de la niña o el niño durante la atención de una emergencia.

Cadena de custodia: conjunto de procedimientos que garantizan la integridad, el manejo adecuado y la trazabilidad de la evidencia relacionada con un evento que pueda tener implicaciones legales.

Convulsión: alteración neurológica súbita, producida por una actividad eléctrica anormal del cerebro, que se manifiesta con movimientos involuntarios y pérdida temporal del control corporal.

Desfibrilador externo automático (DEA): dispositivo portátil que analiza el ritmo cardíaco de una persona en paro y, si es necesario, administra una descarga eléctrica para restablecer un ritmo cardíaco normal.

Deshidratación: pérdida excesiva de agua y electrolitos en el organismo, frecuente en la primera infancia, que puede afectar el estado general de la niña o el niño.

Esguince: lesión de los ligamentos de una articulación, causada por un estiramiento o desgarró brusco, que produce dolor e inflamación.

Hemorragia: pérdida de sangre causada por la ruptura de uno o varios vasos sanguíneos, que puede ser interna o externa.

Luxación: desplazamiento de un hueso fuera de su articulación, que produce dolor intenso, deformidad e imposibilidad de movimiento.

OVACE: obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño que impide el paso del aire hacia los pulmones y requiere maniobras de desobstrucción inmediatas.

Reanimación cardiopulmonar (RCP): conjunto de maniobras de compresiones torácicas y ventilaciones, dirigidas a restablecer la respiración y la circulación en una persona en paro cardiorrespiratorio.

Referencias bibliográficas

American Heart Association. (2020). Guidelines for cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular care.

European Resuscitation Council. (2021). European Resuscitation Council guidelines 2021.

Fiscalía General de la Nación (Colombia). (s.f.). Manual de cadena de custodia.

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. (2020). International first aid, resuscitation and education guidelines.

International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR). (2020). Consensus on science with treatment recommendations (CoSTR).

Ministerio de Salud y Protección Social. (2018). Ruta integral de atención en salud para la promoción y mantenimiento de la salud.

MSD Manual. (2023). Cómo tratar al lactante consciente que se asfixia.

Organización Mundial de la Salud. (2020). Emergency care systems for universal health coverage: Ensuring timely care for the acutely ill and injured.

Osakidetza. (2022). Manual de reanimación cardiopulmonar básica y avanzada en pediatría.

Tortora, G. J., & Derrickson, B. (2021). Principles of anatomy and physiology (16.^a ed.). John Wiley & Sons.

Créditos

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Claudia Johanna Gómez Pérez	Profesional G06. Responsable Ecosistema Virtual de Recursos Educativos Digitales	Centro Agroturístico - Regional Santander
Diana Rocío Possos Beltrán	Responsable de línea de producción	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Laura Brigitte Perea Possos	Experta temática	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Gloria Lida Alzate Suárez	Evaluadora instruccional	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Juan Daniel Polanco Muñoz	Diseñador de contenidos digitales	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Manuel Felipe Echavarria Orozco	Desarrollador full stack	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Ernesto Navarro Jaimes	Animador y productor audiovisual	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Jorge Eduardo Rueda Peña	Evaluador de contenidos inclusivos y accesibles	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Jorge Bustos Gómez	Validador y vinculator de recursos educativos digitales	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima